

amorrónados y útero sub involucionado, en el postparto o el postaborto. En este caso se marcará el círculo amarillo que indica endometritis SI. En caso negativo (no hay evidencia de infección en el endometrio) se marcará NO.

- **Infección ovular**

La infección ovular define como la presencia de manifestaciones clínicas maternas asociadas a la invasión microbiana de la cavidad amniótica normalmente estéril. Los criterios que permiten su diagnóstico son: fiebre >38 grados axilar, taquicardia materna, leucocitosis >15.000/mm³, taquicardia fetal, sensibilidad uterina, líquido amniótico purulento o de mal olor. Ante la presencia de estos elementos clínicos/paraclínicos se marca SI (círculo amarillo), de lo contrario marcar NO.

- **Infección genital**

La infección vulvo-vaginal es un proceso infeccioso genital caracterizado por uno o más de los siguientes sin medición: flujo, prurito vulvar, ardor, irritación, disuria, dispareunia y fetidez vaginal, determinados por la invasión y multiplicación de microorganismos. Ante la presencia de estos elementos clínicos se marca SI (círculo amarillo), de lo contrario marcar NO.

- **Bacteriuria asintomática**

Es la presencia de bacterias en la orina sin causar síntomas, se diagnostica si hay una gran proliferación bacteriana en el urocultivo (un recuento bacteriano igual o superior a 100.000 colonias por cc de orina, o tira reactiva positiva para infección urinaria). Si se presenta esta situación se marcará SI (círculo amarillo), en caso contrario se marcará NO.

- **Pielonefritis**

Se interpretará que la madre embarazada es portadora de una pielonefritis cuando tenga un cuadro clínico caracterizado por dolor lumbar, fiebre y síndrome urinario bajo y/o presente un recuento bacteriano igual o superior a 100.000 colonias por cc de orina, o tira reactiva positiva para infección urinaria. En cualquiera de estos casos se marcará el círculo amarillo que indica pielonefritis SI. En caso negativo (no hay evidencia de infección) se marcará NO.

- **Neumonía**

Es la inflamación de los pulmones, causada por la infección por un virus o una bacteria, que se caracteriza por la presencia de fiebre, escalofríos, dolor intenso en el tórax, tos y expectoración muco-purulenta y cuya confirmación es radiológica. En caso que esté presente se marcará SI, en caso que no haya evidencia de neumonía se marcará NO.

- **Mastitis**

Es una afección inflamatoria de la mama, la cual puede acompañarse o no de infección asociada a la lactancia. En caso que esté presente se marcará SI, en caso que no haya evidencia se marcará NO.

- **Gonorreya**

Enfermedad infecciosa de transmisión sexual que se caracteriza por la inflamación de las vías urinarias y los genitales y que produce un flujo excesivo, inflamación y disuria y es producida por la colonización por el gonococo. En caso que esté presente se marcará SI, en caso que no haya evidencia se marcará NO.

Handwritten notes and signatures on the bottom of the page, including "CP 48" and "H. EC".

El diagnóstico de la implantación del embarazo fuera de la cavidad endometrial se anotará como embarazo ectópico SI, cuando la implantación del embarazo sea dentro de la cavidad uterina se marcará NO.

- **Placenta previa**

Cuando la inserción de la placenta cubra total o parcialmente el orificio cervical interno se anotará la opción placenta previa SI. Clínicamente suele manifestarse por un sangrado de color rojo rutilante, con coágulos, sin dolor y que puede presentarse en episodios reiterados a lo largo del embarazo, siendo cada vez más frecuentes e intensos. El tono uterino suele ser normal. Cuando la inserción de la placenta sea normal se marcará NO.

- **Acretismo placentario**

Cuando la placenta no se desprende normalmente en el postparto, debido a que ha invadido o penetrado más allá del endometrio se marcará el círculo amarillo SI. Cuando el desprendimiento se hace sin inconvenientes o se descarta una inserción anormal de la placenta, se anotará NO.

- **Desprendimiento Prematuro de la Placenta Normalmente Inserta (DPPNI)**

Se refiere al desprendimiento prematuro de la placenta normalmente inserta (DPPNI), también conocido como Abrupto Placentae. Puede manifestarse clínicamente por un sangrado rojo oscuro, sin coágulos y que se acompaña de dolor intenso a nivel uterino, pudiéndose notar la hipertensión a nivel del útero. Cada vez que se detecte que la placenta se ha desprendido total o parcialmente, antes de la salida del recién nacido se anotará SI, cuando la placenta sale luego del nacimiento y no presenta hematomas retroplacentarios, se marcará NO.

- **Rotura uterina**

Corresponde a una solución de continuidad a nivel del cuerpo uterino que se produce generalmente durante el trabajo de parto. Se acompaña de metrorragia y dolor abdominal. Puede estar precedida por signos y síntomas que constituyen el síndrome de pre-ruptura uterina caracterizado por:

- Distensión marcada del segmento inferior con formación de un anillo palpable (signo de Bandl).
- Los ligamentos redondos se ponen en tensión y parecen cuerdas que tiran del segmento (signo de Frommel).
- Metrorragia escasa de sangre oscura (signo de Pinard).

Cuando estén presentes estos signos o se confirme la rotura se marcará SI, en caso que estén ausentes se marcará NO.

- **Hemorragia postparto**

Toda pérdida de sangre superior a 500 cc postparto vaginal o superior a 1000 cc posteriormente a la realización de una cesárea será considerada como una hemorragia postparto y en ese caso se marcará el círculo amarillo que indica SI. En caso de pérdidas normales o inferiores a los límites previamente citados, se anotará NO.

- **Atonía uterina**

Cuando se presenta falta de contractilidad adecuada de las fibras miométricas después de un parto o de una operación cesárea, que impide que se realice una hemostasia fisiológica provocando una hemorragia. En caso que ocurra falta de contractilidad se anotará SI, en caso que las fibras miométricas se contraigan normalmente se anotará NO.

- **Desgarros**

Un sangrado excesivo y de color rojo brillante puede ser signo de la existencia de desgarros. Se da cuando ocurre una lesión como consecuencia del parto que compromete la vagina, vulva y periné en grado variable y extensión diversa. Los desgarros perineales, cervicales y vaginales suelen ser un evento frecuente y generalmente no revisten gravedad, por lo tanto, esta variable se reserva exclusivamente a desgarros que provoquen una hemorragia superior a 500 cc o que por su extensión comprometan zonas anatómicas relevantes como uretra o esfínter anal o recto, etc. En caso que exista un desgarro con estas características se anotará SI, en caso que no haya ocurrido se anotará NO.

- **Restos**

La existencia de residuos de la placenta que puedan quedar adheridos a la pared del útero, puede producir una hemorragia porque ésta no se contrae para evitarla. En caso que se constaten residuos se anotará SI, en caso que no haya ocurrido se anotará NO.

- **Defecto de coagulación**

Son enfermedades o afecciones producidas por alteraciones en las plaquetas o factores de la coagulación y que determinan modificaciones anormales de la coagulación.

5.4 Trastornos metabólicos

TRASTORNOS METABÓLICOS no ☐ si ☐			
DIABETES MELLITUS no ☐ si ☐		TRASTORNOS TIROIDEOS no ☐ si ☐	
Tolerancia oral a la glucosa anormal	no ☐ si ☐	Hipotiroidismo	no ☐ si ☐
D.M. insulino dependiente previa	☐ ☐	Hipertiroidismo	☐ ☐
D.M. no insulino dependiente previa	☐ ☐	Crisis tiroidea	☐ ☐
D.M. gestacional	☐ ☐	Otro trastorno metabólico	☐ ☐ →

Trastornos Metabólicos es una variable resumen. Esta sección tiene dos sub secciones: diabetes mellitus y trastornos tiroideos. Se debe marcar SI en esta variable resumen en caso que haya marcado SI en al menos una de las dos variables correspondientes a las sub-secciones (diabetes mellitus y trastornos tiroideos). Cuando no haya marcado ninguna se anotará NO. Las sub-secciones son:

Sub-sección 1. Diabetes Mellitus (DM)

Marque SI en caso que se presente una de las siguientes variables relacionadas con la Diabetes Mellitus (DM).

- **Tolerancia oral a la glucosa anormal**

Existe tolerancia oral a la glucosa anormal si se observan estos valores sanguíneos luego de ingesta de 75 gr de glucosa: glicemia ayunas 92-125 mg/dL en ayunas; mayor/igual a 180 mg/dL en 1 hora; entre 153-199 mg/dL en 2 horas (WHO/NMH/MND/13.2). Si se observa al menos uno de estos resultados, se marcará SI, en caso contrario marcará NO.

- **D.M. insulino dependiente previa**

Handwritten signatures and initials:
 amson
 C.P. 50
 H.K.C.
 MB
 (initials)

Si existe un diagnóstico previo al embarazo de diabetes mellitus (DM) insulino dependiente se marcará que SI, en caso contrario se marcará que NO.

- **D.M. no insulino dependiente previa**

Si existe un diagnóstico previo al embarazo de diabetes mellitus (DM) que no presenta dependencia a la insulina se marcará que SI, en caso contrario se marcará que NO.

- **D.M. gestacional**

Diabetes que se diagnostica durante el embarazo marcará que SI, en caso contrario se marcará que NO.

Sub- sección 2. Trastornos Tiroideos

Marque SI en caso que se presente una de las siguientes variables relacionadas con Trastornos Tiroideos.

- **Hipotiroidismo**

En caso que exista un trastorno endocrino producido por un déficit de hormonas tiroideas, se marcará que SI, en caso contrario se marcará que NO.

- **Hipertiroidismo**

En caso que exista un trastorno endócrino producido por una hipersecreción de hormonas tiroideas, se marcará que SI, en caso contrario se marcará que NO.

- **Crisis tiroidea**

Ante una mujer embarazada con antecedentes de hipertiroidismo, que comienza en forma súbita con una acentuación de los síntomas de hiperfunción tiroidea tales como hipertermia, taquicardia y alteración del estado mental con agitación severa, se deberá pensar en una crisis tiroidea o tirotoxicosis. Además del aumento de la frecuencia cardíaca se pueden ver otros síntomas de la esfera cardiovascular (distintos tipos de arritmias, fibrilación auricular, taquicardia supra ventricular y extrasístoles ventriculares e hipertensión sistólica). También síntomas neurológicos como agitación, labilidad emocional, insomnio, delirio, psicosis, letargia y/o coma. A veces debilidad generalizada, temblor fino distal, mioclonías, coreoatetosis e hiperreflexia pueden acompañar el cuadro. También pueden verse signos físicos como el bocio o la oftalmopatía hipertiroides (retracción palpebral, exoftalmos, edema periorbitario, oftalmoplejía y alteraciones conjuntivales) o la dermatopatía del tipo de mixedema.

Ante una embarazada que presente una crisis tiroidea se deberá marcar el círculo amarillo que dice SI. Cuando no haya signos de una crisis tiroidea se anotará NO.

5.5 Otros trastornos

OTROS TRANSTORNOS		no	si			no	si
Hiperemesis gravídica	☐	☐		Oliguria	☐	☐	
Trombosis venosa prof.	☐	☐		Anemia ferropívia	☐	☐	
Tromboembolismo pulm.	☐	☐		Anemia falciforme	☐	☐	
Embolia L.A.	☐	☐		Enfermedad renal	☐	☐	
Cardiopatía	☐	☐		Neoplasia maligna	☐	☐	
Valvulopatía	☐	☐		Trastorno psiquiátrico	☐	☐	
Convulsiones	☐	☐		Alteración del estado de conciencia	☐	☐	

"Otros trastornos" es una variable resumen. Usted debe marcar SI en caso que haya marcado SI en al menos una de las variables de la sección. Cuando no haya marcado ninguna se anotará NO.

Las variables de la sección son:

- **Hiperémesis gravídica**

Náuseas y vómitos presentes en madres embarazadas, que evolucionan de manera severa, producen deshidratación, pérdida de peso mayor del 5 %, cetonuria y desequilibrio metabólico y electrolítico se deberá marcar SI, en caso contrario se marcará NO.

- **Trombosis venosa profunda (TVP)**

Corresponde a la trombosis venosa profunda, la cual se caracteriza clínicamente por edema, calor y rubor de la extremidad afectada unidos a la presencia de dolor a la dorsi-flexión del pie. El diagnóstico puede ser confirmado por ultrasonografía, flebografía y/o medición del dímero D. Se marcará SI, ante la existencia de una trombosis venosa profunda (TVP). Se anotará NO, si no hay evidencias de ella.

- **Trombo embolismo pulmonar (TEP)**

TEP se refiere a trombo embolismo pulmonar. Se marcará SI, cuando se presente una obstrucción total o parcial de las arterias pulmonares, confirmada por radiología y manifestada clínicamente por 2 o más de los siguientes síntomas: disnea, dolor pleurítico, dolor torácico no retroesternal, hemoptisis, roce pleural o hipoxemia (que corrige con FiO₂ del 40%) y que concurrentemente tiene taquicardia (>90 lpm), febrícula y síntomas en miembros inferiores. Se marcará NO, si no hay evidencias de él.

- **Embolia de líquido amniótico**

La aparición de insuficiencia respiratoria rápida y paro cardíaco, que puede estar seguida por una fase hemorrágica. Los síntomas que pueden indicar la presencia de una embolia de líquido amniótico son:

- Falta de aliento repentina.
- Edema pulmonar.
- Bajada súbita de la presión arterial.
- Insuficiencia circulatoria súbita (colapso cardiovascular).
- Coagulación intravascular diseminada.
- Alteración del estado mental, como ansiedad.
- Náuseas o vómitos
- Escalofríos.
- Aumento de la frecuencia cardíaca.
- Sufrimiento fetal.
- Convulsiones.
- Coma.

Se deberá marcar SI en caso que lo presente o de lo contrario se marcará NO.

- **Cardiopatía**

Ante una madre embarazada con diagnóstico de cardiopatía (patologías cardíacas que no sean alteraciones valvulares que se describen aparte) se deberá marcar el círculo amarillo que dice SI en caso contrario se anotará NO.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "C", "52", "Hec", and others.]

- **Valvulopatía**

Es una patología cardíaca que puede ocurrir a partir de válvulas permeables o estrechas. Ante una madre embarazada que presente antecedentes de valvulopatía se deberá marcar el círculo amarillo que dice SI. Cuando no haya diagnóstico, se anotará NO.

- **Convulsiones**

La aparición de secuencias repetidas de contracción y distensión involuntaria de un músculo o un grupo muscular, en general brusco y violento será considerada una convulsión. En ese caso se marcará SI, de no haber convulsiones vinculadas se marcará NO.

- **Oliguria**

Se presenta cuando en una madre embarazada presenta cifras de diuresis menores a 0,5 ml/Kg/hora, al menos por 2 horas, se considerará que es portadora de una oliguria y se marcará el círculo amarillo que indica SI, si la diuresis es normal se marcará NO.

- **Anemia ferropriva**

Se considera como anemia durante el embarazo cuando la cifra de hemoglobina está por debajo de 11 g/L de sangre y el hematocrito menor que 33% durante el tercer trimestre de la gestación. Se entiende que si la cifra de hemoglobina es menor que 95 g/L, la anemia es intensa. En caso que esté presente, se marcará que SI, de lo contrario se marcará que NO.

- **Anemia falciforme**

Es una enfermedad en la que el organismo produce glóbulos rojos con forma anormal (tienen forma semilunar o de una hoz) y por tanto son destruidos precozmente produciendo anemia. En la gran mayoría de los casos este es un diagnóstico que la embarazada tiene desde antes del embarazo. En caso que esté presente, se marcará que SI, de lo contrario se marcará que NO.

- **Enfermedad renal**

Es la pérdida de la función renal, la cual puede empeorar durante el embarazo y se manifiesta por valores anormalmente elevados de creatinina y urea en sangre. En caso que esté presente, se marcará que SI, de lo contrario se marcará que NO.

- **Neoplasia maligna**

Diagnóstico de algún tipo de cáncer actual en una madre embarazada. En caso que esté presente, se marcará que SI, de lo contrario se marcará que NO.

- **Trastorno siquiátrico**

En el caso de que exista una perturbación de la actividad intelectual, el estado de ánimo o el comportamiento. El diagnóstico debe ser hecho por un psiquiatra. En caso que esté presente, se marcará que SI, de lo contrario se marcará que NO.

- **Alteraciones del estado de conciencia**

Se refiere a la pérdida que tiene la madre embarazada de la capacidad de percatarse de sí misma y de su entorno. Puede ir desde ligera confusión, somnolencia a estados más profundos como el coma. Por su gravedad el coma ha sido ubicado dentro de las variables de Near Miss. En cualquier alteración del estado de alerta, aún el coma se marcará el círculo amarillo que indica SI, cuando no haya alteraciones de la conciencia se marcará NO.

- **Otros**

Cualquier otra patología considerada relevante por el profesional tratante. Debe especificarse.

5.6 Complicaciones obstétricas

COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS				no	si
	no	si		no	si
Parto obstruido	☐	☐	Polihidramnio	☐	☐
Rotura prolongada de memb.	☐	☐	Sufrimiento fetal agudo	☐	☐
Oligoamnios	☐	☐	Restricción de crecimiento intrauterino	☐	☐

Complicaciones obstétricas es una variable resumen. Usted debe marcar SI en caso que haya marcado SI en al menos una de las variables de la sección. Cuando no haya marcado ninguna se anotará NO.

Las variables de la sección son:

- **Parto obstruido**

Cuando el paso del feto hacia el exterior se ve obstruido por algún factor (los huesos de la pelvis de la madre, tumor previo u otros). En caso que esté presente, se marcará que SI, de lo contrario se marcará NO.

- **Rotura prolongada de membrana**

Rotura de las membranas amnióticas de más de 18 hs de evolución. En caso que esté presente, se marcará que SI, de lo contrario se marcará NO.

- **Oligoamnios**

Disminución del líquido amniótico (ecografía que muestre ILA < 5-6 en el tercer trimestre). En caso que esté presente, se marcará SI, de lo contrario se marcará NO.

- **Polihidramnios**

Aumento del líquido amniótico (ecografía que muestre ILA > 18-24 en el tercer trimestre). En caso que esté presente, se marcará SI, de lo contrario se marcará NO.

- **Sufrimiento fetal agudo**

Perturbación metabólica compleja debida a una disminución de los intercambios feto-maternos, de evolución relativamente rápida, que lleva a una alteración de la homeostasis fetal y que puede conducir a alteraciones tisulares irreparables o a la muerte fetal. En caso que esté presente, se marcará SI, de lo contrario se marcará NO.

- **Restricción de crecimiento intrauterino**

Retraso del crecimiento del feto, manifestado por un peso por debajo del percentil 10 esperado para la edad gestacional. En caso que esté presente, se marcará que SI, de lo contrario se marcará NO.

[Handwritten signatures and notes in the bottom right corner, including a date '54' and various initials.]

- **Balones de compresión / hidrostáticos**

Utilización de balones de compresión / hidrostáticos para el tratamiento de la hemorragia. Se marcará SI cuando se utilice el procedimiento, NO, cuando no se realice estos procedimientos, S/D cuando se desconoce el dato.

Sección 6: Postparto

Objetivo: Evidenciar el bienestar de la madre durante el puerperio e identificar signos de alerta que pueden poner en riesgo la vida de la madre.

POSTPARTO										
día	hora	T°C	TA	FR	pulso	Sat	est. conc.	mov. uter.	loquios	SCORE MAMA

Esta sección está destinada al registro de los controles del puerperio. Se anotará los tres primeros controles realizados cada 15 minutos, del total de 8 controles que recomienda la norma, los demás deberán anotarse en la hoja de evolución Formulario 005, durante las dos primeras horas después del parto:

- 1.-El día y la hora: el momento del examen puerperal,
- 2.-Temperatura al momento del examen en grados centígrados y décimas (ej.: 36,4 °C).
- 3.-Tensión arterial: (TA) en mm de Hg,
- 4.-Frecuencia respiratoria: es el indicador más sensible del deterioro de la fisiología y es necesario documentar en cada medición de signos vitales.
- 5.-Pulso número de latidos por minuto
- 6.-Saturación: La saturación de oxígeno se supervisa de forma rutinaria en mujeres en período posparto, ya que determina la gravedad de una enfermedad.
- 7.-Estado de conciencia: El nivel de conciencia debe ser evaluado en todas las madres embarazadas. Una alerta de gravedad se desencadena dependiendo el puntaje:
 - Alerta y consciente = 0
 - Responde a la voz = 1
 - Responde al dolor = 2
 - No responde = 3
- 8.-Involución uterina: se refiere a si existe o no Globo de seguridad de Pinnard y el grado de involución del útero contraído (cont), flácido (flac).
- 9.-Loquios: examinar principales características: fetidez, cantidad, coágulos, sanguinolentos, etc. Colocar según estos parámetros son normales o anormales.
- 10.-Sumatoria SCORE MAMA: El puntaje se calcula dependiendo del valor en el signo vital obtenido en la medición de signos vitales de la madre en el posparto.

6.1 Inmunoglobulina anti - Rh (D)

Inmunoglobulina anti Rh D	no ☐	si ☐	n/c ☐
---------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Marcar con una (X) según corresponda (si/no/no aplica), si se administra o no la vacuna.

La inmunoglobulina anti-Rh (D) es un anticuerpo pasivo que solo evita la inmunización, hecho que obliga a administrar una nueva dosis cada vez que se produce una nueva exposición. Utilizada para la prevención de la Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido, de madres Rh negativas y la profilaxis de la inmunización en personas Rh negativas después de una transfusión incompatible de sangre total, concentrado de eritrocitos o plaquetas Rh positivo.

Sección 7: Morbilidad Materna Grave Variables identificar casos de (NEAR MISS)

Marcar con una (X) la casilla que corresponda.

Morbilidad grave es aquella que presenta una mujer que casi muere pero sobrevive a una complicación que ocurre durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días de terminado el embarazo.¹⁵

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone que además de la vigilancia de la Mortalidad Materna, se realice la vigilancia de la Morbilidad Materna Grave por considerar que ésta última ofrece ventajas como la posibilidad de analizar un mayor número de casos, la disponibilidad de la fuente primaria de la información (que en este caso es la mujer sobreviviente), y la menor prevención por parte de los equipos de salud para su análisis gracias a las pocas implicaciones legales asociadas al manejo de cada caso en particular.

Mortalidad Materna Grave

Criterios Clínicos disfunción órgano - sistema: alteración de signos vitales, estado de conciencia y disminución de diuresis, asociado a pérdidas hemáticas, procesos infecciosos.

Laboratorio: cualquier alternación dentro de los criterios de atención.

Criterios de enfermedades sobre agregadas: trastornos hipertensivos del embarazo, síndrome de Hellp, edema pulmonar, hemorragia por aborto o embarazo ectópico, o post parto, ruptura uterina, acretismo placentario, desprendimiento de placenta normo inserta, sepsis, endometritis, pielonefritis, neumonía, Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS), trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, otras afecciones como crisis tiroidea o cetoacidosis diabética.

Intervenciones realizadas: remoción de restos ovulares, alumbramiento manual, uterotónicos para hemorragia, activación de código rojo, sutura de desgarros complicados, administración de hemoderivados, ligadura de arterias uterinas o embolización de las mismas, laparotomía, uso de antibióticos intravenosos para complicación infecciosa.

Causa principal de morbilidad: definida como la afección primaria causante de la necesidad de tratamiento o investigación que tuvo la madre embarazada, o la lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la morbilidad.

Si hay más de una afección así caracterizada, debe seleccionarse la que se considera la mayor causante del uso de recursos.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "CP 2 58" and "H. C."

Otras causas: aquellas que coexistieron o se desarrollaron durante el episodio de atención y afectaron el tratamiento de la embarazada. Las que hayan afectado a la embarazada pero que no inciden en el episodio actual no se deben registrar.

Se realizará una clasificación en directas o indirectas, según la causa:

Causas directas: Mortalidad Materna Grave que es producida por complicaciones del embarazo, parto y/o puerperio, por intervenciones, omisiones, tratamiento incorrecto o por una cadena de eventos resultantes de uno de ellos. Ejemplo: pre-eclampsia.

Causas indirectas: Mortalidad Materna Grave que es producida por enfermedades preexistentes o enfermedades que se desarrollan durante el embarazo y no se deben a causas obstétricas directas, pero que son agravadas por el embarazo. Ejemplo: cardiopatía.

Consta de 3 secciones:

1. Criterios Clínicos/ Disfunción órgano - sistema
2. Criterios de Laboratorio
3. Criterios de Intervenciones

7.1 Criterios clínicos / disfunción órgano-sistema

CRITERIOS CLÍNICOS/DISFUNCIÓN ÓRGANO-SISTEMA					
Cardiovascular:	si	no	Renal:	si	no
Shock	☐	☐	Oliguria resistente a líquidos diuréticos	☐	☐
Paro cardíaco	☐	☐	Hematológicos/coagulación:		
Hepático:			Alteraciones de la coagulación	☐	☐
Ictericia en preeclampsia	☐	☐	Neurológico:		
Respiratorio:			Coma	☐	☐
Cianosis aguda	☐	☐	Inconsciencia prolongada >12 hs	☐	☐
Respiración jadeante (gasping)	☐	☐	Accidente Cerebro Vascular	☐	☐
Taquipnea severa FR > 40rpm	☐	☐	Convulsiones incontrolables/ estado de mal epiléptico	☐	☐
Bradipnea severa FR < 6rpm	☐	☐	Parálisis generalizada	☐	☐

1. Cardiovascular

• Shock

Se estará frente a elementos orientadores de Shock cuando se asocien algunos de los siguientes síntomas o signos:

- Ansiedad o agitación, confusión mental y o coma.
- Palidez cutánea y mucosa con piel fría y sudorosa.
- Oliguria o anuria.
- Polipnea.
- La Presión arterial sistólica se sitúe en 90 mmHg o menos, la PAD sea igual o menor a 60 mmHg.
- La temperatura corporal descienda por debajo de 36° C.

En caso que se estime un cuadro de Shock se marcará el círculo amarillo que dice SI. Si estos síntomas y signos no están presentes, se anotará NO y si se desconoce el dato se marcará S/D.

- **Paro cardíaco**

La pérdida de función cardíaca, caracterizada por la ausencia de latidos cardíacos se denomina paro cardíaco. En estos casos se marcará el círculo amarillo que indica SI, de no haber paro cardíaco se deberá registrar NO y si se desconoce el dato se marcará S/D.

2. Hepático

- **Ictericia en preeclampsia**

La presencia de coloración amarilla en piel y mucosas en una embarazada con preeclampsia es un signo que revela compromiso de la funcionalidad hepática y en esos casos deberá anotarse el círculo amarillo que indica SI, en caso de descartarse una ictericia en una embarazada con preeclampsia se marcará NO y si se desconoce el dato se marcará S/D.

3. Respiratorio

- **Cianosis aguda**

Se entiende por cianosis central, la coloración azulada de las mucosas (labios, lengua y boca). Ante la presencia de cianosis central, como signo clínico de insuficiencia respiratoria, se deberá marcar el círculo amarillo que indica SI, en caso de ausencia de cianosis se marcará NO y si se desconoce el dato se marcará S/D.

- **Respiración jadeante**

También conocida por su expresión en inglés (gasping respiration), consiste en un patrón respiratorio previo a la fase de apnea y que se caracteriza por una respiración anormal, con esfuerzo y frecuencia variable, fácil de distinguir del patrón respiratorio normal. Ante la presencia de respiración jadeante se deberá marcar el círculo amarillo que indica SI, en caso de ausencia de respiración jadeante se marcará NO y si se desconoce el dato se marcará S/D.

- **Taquipnea severa $fr > 40$ rpm**

El aumento exagerado de la frecuencia respiratoria a niveles superiores a 40 respiraciones por minuto se deberá marcar el círculo amarillo que indica SI, en caso de frecuencia respiratoria igual o menor a 40 respiraciones por minuto se marcará NO y si se desconoce el dato se marcará S/D.

- **Bradipnea severa $fr < 6$ rpm**

La disminución de la frecuencia respiratoria a niveles inferiores a 6 respiraciones por minuto, es un signo de extrema gravedad y se deberá marcar el círculo amarillo que indica SI, en caso de frecuencia respiratoria igual o superior a 6 respiraciones por minuto se marcará NO y si se desconoce el dato se marcará S/D.

4. Renal

- **Oliguria resistente a líquidos o diuréticos**

Cuando en una madre embarazada las cifras de diuresis sean menores a 0,5 ml/Kg/hora, y a pesar de reponer con volumen, hemoderivados o emplear drogas vasoactivas o diuréticos la diuresis no se logra recuperar, se considerará que la embarazada es portadora de una oliguria resistente a líquidos o diuréticos y se marcará el círculo amarillo que indica SI, si la diuresis es normal o se ubica en niveles superiores a los establecidos, se marcará NO y en caso que no se conozca el dato se marcará S/D.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "P", "C.P.", "H.C.", and "60".

5. Hematológicos/coagulación

• Alteraciones de la coagulación

Cuando en una madre embarazada se advierta clínicamente una incapacidad para formar coágulos por severa alteración del sistema de la coagulación se marcará se considerará que la embarazada es portadora de alteraciones de la coagulación y se marcará el círculo amarillo que indica SI, en caso que la formación de coágulos sea normal se marcará NO y en caso que no se conozca el dato se marcará S/D.

6. Neurológico

• Coma

El coma es un estado de pérdida la conciencia en el que “no se emiten palabras, no se obedecen órdenes, no se fija la mirada y no se reacciona ante el dolor”. Cuando exista una depresión neurológica caracterizada por la pérdida de la conciencia, se podrá decir que la embarazada está en coma y se marcará el círculo amarillo que indica SI, en caso contrario se marcará NO y en caso que no se conozca el dato se marcará S/D.

• Inconsciencia prolongada > 12 hs.

Cuando exista una pérdida de la conciencia que no sea inducida por medicamentos y que persista por 12 horas o más, se marcará el círculo amarillo que indica SI. Si la inconsciencia revierte antes de las 12 horas o no existe inconsciencia se marcará NO y en caso que no se conozca el dato se marcará S/D.

• Accidente cerebro vascular

Los síntomas de un accidente cerebro vascular, pueden ser muy variados en función del área cerebral afectada. Desde síntomas puramente sensoriales a los puramente motores, pasando por los síntomas sensitivo-motores. Los más frecuentemente diagnosticados son los siguientes:

- ✓ Pérdida de fuerzas o parálisis en miembros o en la cara.
- ✓ Dificultad al caminar, pérdida de equilibrio o de coordinación.
- ✓ Dificultad para expresarse o hacerse entender.
- ✓ Pérdida de la visión en uno o ambos ojos.

Cuando la embarazada presente alguno de los síntomas descritos podrá sospecharse la presencia de AVE y en ese caso se marcará el círculo amarillo que indica SI. Cuando no existan estos síntomas se marcará NO y en caso que no se conozca el dato se marcará S/D.

• Convulsiones incontrolables/estado de mal epiléptico

Cuando la crisis epiléptica persiste durante un tiempo suficientemente prolongado (30 o más minutos) o se repiten con intervalos suficientemente breves como para crear una condición epiléptica fija y duradera se marcará el círculo amarillo que indica SI. Si no hay crisis o las características no evidencian la gravedad que se describe se marcará NO y en caso que no se conozca el dato se marcará S/D.

• Parálisis generalizada

Ante la existencia de parálisis generalizada se marcará SI, cuando no la haya se anotará NO y en caso que no se conozca el dato se marcará S/D.

7.2 Laboratorio

LABORATORIO			
Laboratorio:	si	no	s/d
Plaquetas < 50000por ml	☐	☐	☐
Creatinina > 300 micromoles/o > 3,5mg/dl	☐	☐	☐
Bilirrubina > 100 moles/o > 6,0 mg/dl	☐	☐	☐
pH < 7.1	☐	☐	☐
Po2 < 90% > 1 hora	☐	☐	☐
PaO2/FiO2 < 200 mmHg	☐	☐	☐
Lactato > 5umol/L o 45mg/dl	☐	☐	☐

- **Plaquetas < 50.000**

Se anotará SI, cada vez que los niveles del recuento plaquetario sean menores a 50.000 plaquetas por cc. Se marcará NO, cuando los valores sean iguales o superiores 50.000 plaquetas. En caso que se desconozca si el examen fue realizado o no se cuente con el resultado al momento del cierre de la historia se indicará S/D.

- **Creatinina > 300 micromoles/L o > 3,5mg/dL**

Se anotará SI, cada vez que los niveles de creatinina en sangre sean iguales o superiores a 300 micromoles/l o iguales o mayores a 3,5 mg/dL. Se marcará NO, cuando los valores sean inferiores a 300 micromoles/l o a 3,5 mg/dL. En caso que se desconozca si el examen fue realizado o no se cuente con el resultado se indicará S/D.

- **Bilirrubina > 100 moles/L o > 6,0 mg/dL**

Se anotará si, cada vez que los niveles de Bilurribina sérica superen los 100 moles/L o los 6,0 mg/dL. Se marcará NO, cuando los valores sean iguales o inferiores a 100 moles/L o 6,0 mg/dL. En caso se desconozca si el examen fue realizado o no se cuente con el resultado se indicará S/D.

- **PH < 7,1**

Si las cifras de pH son menores a 7,1 se marcará el círculo amarillo que dice SI, cuando las cifras de pH sean iguales o superiores a 7,1 se marcará NO y en caso que se desconozca si el examen fue realizado o no se cuente con el resultado se indicará S/D.

- **PO2 < 90% > 1 hora**

Se marcará SI, cuando los niveles de la presión parcial de oxígeno en sangre sea menor a 90% al menos por un período de una hora. Se anotará NO, cuando los valores de la PO2 sean iguales o inferiores a 90%. En caso que se desconozca si el examen fue realizado o no se cuente con el resultado se indicará S/D.

- **PaO2 /FiO2 < 200 mmHg > 1 hora**

Se marcará SI, cuando los niveles de la relación entre la presión parcial de oxígeno (PaO2) dividida entre la fracción inspirada de oxígeno (FiO2) sea menor a 200 mmHg. Se anotará NO, cuando los valores de ésta relación sean mayores o iguales a 200 mmHg. En caso que se desconozca si el examen fue realizado o no se cuente con el resultado se indicará S/D.

- **Lactato > 5umol/L o 45 mg/dL**

Se marcará SI, cuando los niveles de Lactato en sangre sean mayores 5 micromoles/L o 45 mg/dL. Se anotará NO, cuando los valores de Lactato sean iguales o menores a 5

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

micromoles/L o 45 mg/dL. En caso que se desconozca si el examen fue realizado o no se cuenta con el resultado se indicará S/D.

7.3 Intervenciones

INTERVENCIÓNES	
Administración continua de agentes vasoactivos	☐ SI ☐ NO ↓ Cuál/es
Intubación y ventilación no relacionada con la anestesia	☐ SI ☐ NO ↓ días
Administración > 3 vol de hemoderivados	☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO días
Ingreso de UCI > 7 días	☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO días
Histerectomía	☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO
Dilatación en caso de IRA	☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO
Reanimación cardio-pulmonar	☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO

Opciones Aneur Misa
FLASQO-3VOL
CAMS-5VOL

- **Administración continua de agentes vaso activos**

Se anotará SI, cada vez que se requiera el uso sostenido de inotrópicos para el mantenimiento de la función cardíaca y de la presión arterial. Se marcará NO, cuando no haya sido administrado un agente vasoactivo. En caso se desconozca si se aplicaron o no dichos agentes, se indicará S/D.

- **Cuál/es**

Si se ha marcado SI en la opción ADMINISTRACIÓN CONTINUA DE AGENTES VASOACTIVOS, bajo la denominación CUÁL/ES aparece una variable de campo abierto para que el profesional pueda escribir el nombre del o de los inotrópicos empleados usados (dopamina, dobutamina, etc).

- **Intubación y ventilación no relacionada con la anestesia**

Esta variable está dirigida a registrar episodios que requieran soporte ventilatorio en cualquier circunstancia o más allá de lo estimado como normal, luego de un procedimiento anestésico en caso de una cesárea, un legrado u otro procedimiento quirúrgico. Si una madre es intubada y/o ventilada más allá del período de recuperación postanestésico o sin vinculación a un procedimiento anestésico, se marcará el círculo amarillo que indica SI. Se marcará NO, cuando no haya sido intubada y ventilada, se indicará S/D.

- **Días**

Cuando se haya marcado si en la variable INTUBACIÓN Y VENTILACIÓN NO RELACIONADA CON LA ANESTESIA, se deberá indicar en una variable de tipo numérico la cantidad de días completos que la madre permaneció en estas circunstancias.

- **Administración ≥ 3 vol de hemoderivados**

Marcar SI, cada vez que se transfundan 3 volúmenes o más relacionados con el evento agudo. Anotar NO cuando no se lo haya hecho, S/D cuando se desconoce el dato.

- **Ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos UCI ≥ 7 días**

Se marcará SI cuando la madre embarazada sea ingresada a unidad de cuidados intensivos por 7 o más días, de lo contrario se marcará NO o de no haber datos SD.

- **Histerectomía**

Si una paciente es sometida a una histerectomía (total o subtotal) debido a una complicación del embarazo, parto, puerperio y/o aborto, se marcará el círculo amarillo que indica SI. Se marcará NO, cuando no se haya realizado una histerectomía. Cuando se desconozca si se efectuó una histerectomía, se indicará S/D.

- **Diálisis en caso de Insuficiencia Renal Aguda (IRA)**

Si una paciente es sometida a diálisis renal por la aparición de una Insuficiencia Renal Aguda (IRA) debido a una complicación del embarazo, parto, puerperio y/o aborto, se marcará el círculo amarillo que indica SI. Se marcará NO, cuando no se haya efectuado diálisis. Cuando se desconozca si se efectuó diálisis, se indicará S/D.

- **Reanimación cardio pulmonar**

Si una paciente recibe reanimación cardiopulmonar, se marcará el círculo amarillo que indica SI. Se marcará NO, cuando no se haya efectuado reanimación cardiopulmonar, cuando se desconozca si se efectuó reanimación cardiopulmonar, se indicará S/D.

Sección 8: Recién nacido

RECIÉN NACIDO				P. CEFÁLICO cm	
SEXO		PESO AL NACER		LONGITUD cm	
H	M				
☐	☐				
no definido ☐		g			
		<2500 g ☐ >4000 g ☐			

Objetivo: evidenciar las condiciones del recién nacido, el manejo adecuado en los primeros minutos de vida, y las intervenciones implementadas de prevención, así como el tratamiento de las complicaciones.

Los datos de esta sección se obtienen al momento de la recepción del recién nacido.

Los recién nacidos sanos, aunque no presenten ningún problema, requieren una serie de cuidados, procedimientos, de una valoración cuidadosa de su estado general y de la correcta instauración de la lactancia.

Un recién nacido puede considerarse aparentemente sano si es a término (≥ 37 semanas de gestación), si su historia (familiar, materna, gestacional y perinatal), si su examen físico y su adaptación lo garantizan.

Criterios para clasificar al recién nacido (RN) al nacimiento:

- **Recién nacido (RN) o neonato:** Niño/a que nace vivo/a, producto de una gestación de 22 semanas o más; desde que es separado/a del organismo de la madre hasta que cumple 28 días de vida extrauterina.
- **Recién nacido con bajo riesgo al nacer:** Recién nacido que cumple con los siguientes criterios: rosado/a, llanto fuerte, adecuada respiración, activo/a,

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page, including a date stamp "01/30/12" and a time stamp "12:04".

frecuencia cardiaca >100 latidos por minuto, peso >2.500 gramos, edad gestacional >37 semanas de gestación.

- **Recién nacido con mediano riesgo al nacer:** Recién nacido que cumple con los siguientes criterios: peso entre 2000 gramos o < y 2500 gramos o > ó entre 3500 y 4000 gramos, edad gestacional entre 35 y 37 semanas de gestación.
- **Recién nacido con alto riesgo al nacer:** Recién nacido que cumple con los siguientes criterios: peso > 4000 ó < 2000 gramos, edad gestacional <35 ó > 41 semanas, ruptura prematura de membranas mayor de 24 horas (en <2000 gramos o < 35 semanas), anomalías congénitas mayores, fiebre materna, infección uterina, cianosis persistente, trauma importante al nacimiento, liquido meconial, madre Rh (-).¹⁶

8.1 Sexo

Marcar con una (X) el casillero que corresponda (hombre, mujer ó no definido).

8.2 Peso al nacer

Anotar en el recuadro correspondiente el peso en gramos al nacer y marcar con una (X) en el casillero amarillo, si el peso es menor de 2500 gramos. ó mayor de 4000 gramos.

El peso del recién nacido se ha constituido una de las variables predictoras de la morbilidad y mortalidad infantil. Cuanto menor es el peso, mayor es la probabilidad de morir durante el primer año de vida, siendo el bajo peso al nacer el mayor determinante de la mortalidad en este grupo poblacional y el responsable del 66 % de todas las muertes neonatales (1). Una de las variables antropométricas más utilizadas para evaluar el crecimiento fetal es el peso al nacer y, una tabla que relacione éste con la edad gestacional en ese momento, permite la clasificación de los recién nacidos según los percentiles, por ejemplo: recién nacidos grandes, los que se encuentran por encima del percentil 90 o recién nacidos pequeños, los que se hallan por debajo del percentil 10.¹⁷

Según el peso al nacer se clasifica de la siguiente manera:

Recién nacido con bajo peso al nacer (BPN):

- 1.-**Bajo peso al nacer (BPN)**, cuando se ubica en la curva entre 500 y 2.500 gramos, independiente a su edad gestacional. Es decir, menor o igual a 2.500 gramos.
- 2.-**Muy bajo peso al nacer (MBPN)**, cuando se ubica en la curva entre 1.000 y 1.500 gr, independiente de su edad gestacional, o sea < 1.499 gr.
- 3.-**Extremado bajo peso al nacer (EBPN)**, cuando se ubica en la curva entre 500 y 999 gr, independiente de su edad gestacional, o sea < 1.000 gr.
- 4.-**Recién Nacido con peso alto al nacimiento:**
- 5.-**Macrosómico:** Es decir cuando el peso del recién nacido es de 4000 gramos o más.

8.3 Perímetro cefálico en centímetros

Es un indicador del desarrollo neurológico a partir de la evaluación indirecta de masa cerebral. En los prematuros se espera un aumento de 0.1 a 0.6 cm a la semana. Sin embargo, es normal que durante la primera semana de vida extrauterina, el perímetro disminuya alrededor de 0.5 cm, debido a la pérdida de líquido extracelular.

En los recién nacidos a término se espera una ganancia promedio de 0.5 cm a la semana durante los tres primeros meses de vida. Cuando el aumento es mayor a 1.25 cm a la semana es un signo de sospecha de hidrocefalia o hemorragia intraventricular.

Por el contrario, si la ganancia es mínima o nula, podría existir una patología neurológica asociada con microcefalia.

El perímetro cefálico de los prematuros también debe ser corregido para la edad gestacional hasta los 24 meses de edad, considerando la validez de las tablas de referencia para prematuros¹⁸.

Ubicar la medida del perímetro cefálico en las curvas correspondientes, ayuda a detectar anomalías en forma precoz (macrocefalia, por encima del perímetro cefálico 90 o microcefalia, por debajo del perímetro cefálico 10).¹⁵

Anotar en el recuadro correspondiente, la medida en centímetros.

8.4 Longitud en centímetros cm

Es un indicador del tamaño corporal y de la longitud de los huesos. Tiene la ventaja sobre el peso porque no se ve alterada por el estado hídrico del paciente y los cambios a largo plazo reflejan el estado de nutrición en forma crónica.

Específicamente, el índice peso/longitud es un indicador de desnutrición.

El neonato debe ser colocado en posición supina, con el cuerpo alineado en posición recta sobre el eje longitudinal del paidometro, de manera tal que los hombros y la cadera tengan contacto con el plano horizontal y que los brazos se encuentren a los lados del tronco. La coronilla de la cabeza debe tocar la base fija del paidometro y debe ser colocada en el plano de Frankfort (línea imaginaria trazada desde el extremo inferior de la órbita hasta el borde superior del conducto auditivo externo); es decir, alineado perpendicularmente al plano horizontal.

Anotar en el recuadro correspondiente, la longitud del recién nacido en centímetros.

8.5 Edad gestacional

EDAD GESTACIONAL	
sem.	días.
☐ FUM ☐ ECO ☐ ESTIMADA	

La valoración de la edad gestacional del recién nacido se puede basar en:

1.-Fecha de la última menstruación (FUM): Sumar los días desde el primer día de la última menstruación (F.U.M.) hasta el día del parto y dividirlos entre 7 días que trae cada semana y se obtendrá así la edad gestacional.

2.-Estimación por ecografía fetal precoz: la valoración se la puede realizar con una ecografía temprana (primer trimestre del embarazo), porque mide la longitud del embrión y determina así (con un margen de error de cuatro días) la fecha en la que se produjo la fecundación del óvulo.

3.-Evaluación Física- Estimada: la evaluación de la edad gestacional consiste en la observación de una serie de características físicas y neurológicas a partir de las cuales se asigna una puntuación determinada de la que se infiere una edad gestacional.

Nota: Cuando no se tiene acceso al ultrasonido durante la primera mitad del embarazo. Si la fecha de la última menstruación (FUM) es confiable y los ciclos son de 28 días, la estimación de la EG por FUM sigue siendo útil en la práctica, a pesar de presentar errores aleatorios y sistemáticos.

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page.

00000056

Anotar en el recuadro correspondiente, la edad gestacional en semanas completas y días, marcar con una (X) según corresponda, anotar si fue calculada a partir de la FUM (fecha de la última menstruación), por Eco (Ecografía) ó por evaluación física -estimada.

8.6 Peso EG (peso para edad gestacional)

PESO E.G.	
adec.	☐
peq.	☐
gde.	☐

Se refiere al peso del recién nacido en relación a su edad gestacional.

Se usa un patrón (tablas de referencia de la distribución de peso en las diferentes edades gestacionales - percentiles) de acuerdo a donde se ubique en esta gráfica, el recién nacido podrá ser catalogado como "adecuado, "pequeño" o "grande, para la edad gestacional.

Marcar con una (X) según corresponda (adecuado, pequeño, grande).

8.7 Apgar en minutos

APGAR (min)		
1 ^{er}		
5 ^{to}		
10 ^{mo}		
		n/a

La valoración de Apgar es un método objetivo de cuantificar la condición del recién nacido, por lo común se asigna al minuto de vida y nuevamente a los cinco minutos de vida. Es útil para obtener información acerca del estado general (1 minuto) y de la reacción a la reanimación (a los 5 minutos – 10 minutos).

Sin embargo, la reanimación debe iniciarse antes que se otorgue la valoración, no se debe esperar valorar el apgar para iniciar la reanimación.

Anotar el puntaje de APGAR al 1^{er}, 5^{to} minuto de vida. Cuando la valoración de Apgar es menor de 07 al 5^{to} minuto de vida, se debe realizar una valoración adicional al 10^{mo} minuto¹⁹, si el Apgar al 5^{to} minuto de vida es mayor a 07, marque no aplica.

8.8 Reanimación

	no	si	
REANIMACIÓN	estimulac.	☐	☐
	aspiración	☐	☐
	máscara	☐	☐
	bolsa	☐	☐
	tubo	☐	☐
	endotraq.	☐	☐
	masaje c.	☐	☐
medicación	☐	☐	

Este casillero incluye la lista de procedimientos que pueden ser utilizados durante la recepción/ reanimación del recién nacido.

El tiempo transcurrido durante un procedimiento de reanimación neonatal es de vital importancia para asegurar, no solo la supervivencia, sino la integridad neurológica del niño(a) y una vida de calidad. Cuanto más tiempo se utilice para iniciar una reanimación el deterioro neurológico es mayor¹⁷

Los pasos a continuación son un resumen de la norma a seguir descrito en el texto: *Sexta Edición de Reanimación Neonatal de la Academia Americana de Pediatría, 2011*. Para mayor detalle revisar el documento completo.

Estimulación: seque al neonato completamente al nacer. El secado ayuda a mantener al bebé caliente y estimula la respiración. Un recién nacido mojado con líquido amniótico puede enfriarse aún en una habitación caliente. Seque el cuerpo, brazos, piernas frotando suavemente con un paño. El bebé que está llorando necesita atención rutinaria, el llanto significa que el bebé esta respirando adecuadamente²⁰.

Si el recién nacido no tiene respiraciones adecuadas, se puede proporcionar estimulación táctil adicional, para estimular la respiración. Es importante entender los métodos correctos de estimulación táctil. La estimulación puede ser útil para instar a un bebé a que comience a respirar durante los pasos iniciales de la reanimación, y también se puede usar para estimular la continuación de la respiración luego de una ventilación con presión positiva (VPP).

Aspiración: las secreciones se pueden retirar de las vías aéreas al succionar primero la boca y la nariz, use una pera de goma para eliminar el líquido que pareciera estar bloqueando las vías aéreas, solo si es necesario.

Al usar succión de la pared o de una bomba, la presión de succión debe estar configurada de modo tal que, al bloquear la sonda de succión, la presión negativa (vacío) sea de aproximadamente 100 mm Hg.

La boca se succiona antes que la nariz, para garantizar que no haya nada que el recién nacido pueda aspirar en caso de que boquee cuando se le succione la nariz. Puede recordar que la boca va antes que la nariz pensando en que la "B" está antes que la "N" en el abecedario. Si no se quita las secreciones de la boca y la nariz antes de que el recién nacido respire, es posible que esas secreciones se aspiren a la tráquea y a los pulmones. Cuando esto ocurre, las consecuencias respiratorias pueden ser graves²¹

Máscara: el oxígeno suplementario no suele necesitarse como rutina al principio de una reanimación. No obstante, cuando un recién nacido se ve cianótico o las lecturas del oxímetro son inferiores a lo esperado durante la reanimación, es probable que los niveles de oxígeno aumenten más rápidamente si se administra una concentración de oxígeno superior al 21% del oxígeno en el aire del ambiente.

Pero la administración de oxígeno al 100% probablemente aumente las saturaciones de oxígeno más rápidamente que lo que sucedería en un bebé sano después del nacimiento, e incluso podrían alcanzarse niveles tóxicos. Esto es particularmente probable si el bebé es prematuro, o si la administración de oxígeno dura más de algunos minutos, incluso en un bebé nacido a término.

Handwritten signatures and stamps in the bottom right corner, including a circular stamp with the number 68 and the text "U.E.C." and "P.D."

Lo mejor es usar una concentración de oxígeno que pueda variarse entre 21 y 100%. Esto requerirá de una fuente de aire comprimido y un mezclador de oxígeno. La máscara debe sostenerse a 2.5 centímetros de las vías aéreas, para mantener la concentración de oxígeno, pero no con tanta firmeza como para que acumule presión dentro de la máscara.¹⁹

Bolsa: si el neonato no respira (apneico) o respira de manera entrecortada, si la frecuencia cardíaca es de menos de 100 latidos por minuto (lpm) aunque respire y/o si la saturación permanece por debajo de los valores objetivo pese a haber aumentado a 100% el oxígeno complementario de flujo libre, el paso a dar a continuación es la administración de ventilación con presión positiva.

Corresponde a la bolsa autoinflable para recién nacidos, tiene un volumen mínimo de aproximadamente 200 ml y un máximo de 750 ml. Los bebés nacidos a término sólo necesitan de 10 a 25 ml por ventilación (4 a 6 ml/kg). Las bolsas más grandes de 750 ml, diseñadas para niños más grandes y adultos, hacen que sea difícil proporcionar volúmenes tan pequeños y administrar presión pico controlada.

La selección de una máscara para usar con un recién nacido en particular depende de lo bien que calce la máscara y se adapte a la cara del recién nacido. La máscara correcta logrará un sello ajustado entre la máscara y la cara del recién nacido.¹⁹

Tubo endotraqueal: la intubación endotraqueal puede realizarse en varios puntos durante la reanimación:

Si hubiera meconio y el bebé presenta respiraciones, tono muscular o frecuencia cardíaca deprimidos, el primer paso que deberá llevar a cabo es la intubación de la tráquea, antes de comenzar con cualquier otra medida de reanimación.

Si la ventilación con presión positiva (VPP) no da como resultado una mejoría clínica adecuada y no hay buenos movimientos del pecho, podría decidir intubar para poder administrar una ventilación adecuada en vez de continuar con los esfuerzos correctivos para optimizar la ventilación con máscara.

Si la necesidad de VPP dura más de algunos minutos, puede optar por intubar para mejorar la eficacia y la facilidad de la ventilación asistida.

Si se necesitan compresiones, la intubación facilitará la coordinación de las compresiones torácicas y la ventilación y maximizará la eficiencia de cada respiración con presión positiva.

Cuando ocurren indicaciones especiales, como por ejemplo una prematuridad extrema, la administración de surfactante o la sospecha de una hernia diafragmática.¹⁹

Masaje Cardíaco: no comience el masaje cardíaco hasta no haber asegurado una ventilación adecuada.

En cualquier momento si hay ausencia de latido cardíaco y la frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto tras 30 segundos de ventilación con presión positiva inicie el masaje cardíaco. **Técnica:** colocar los pulgares (uno al lado del otro en caso de recién nacido a término o uno encima del otro si es pretérmino) sobre el tercio inferior del esternón, por debajo de la línea intermamilar, y el resto de los dedos abrazando el tórax.

La profundidad de la compresión debe ser 1/3 del diámetro antero posterior del tórax. El ritmo de compresión/ventilación debe ser 3/1: Tres compresiones seguidas de una

ventilación¹⁹. Este nivel de reanimación siempre debe realizarse entre dos personas capacitadas.

Medicación: antes de administrar medicamentos en una reanimación intensiva, es preciso comprobar varias veces la eficacia de la ventilación, asegurarse de que haya una adecuada expansión del tórax y estén presentes sonidos respiratorios bilaterales audibles con cada respiración.²²

Marcar con una (X) todos los procedimientos realizados según corresponda (estimulación, aspiración de boca y nariz, administración de oxígeno con máscara, administración de oxígeno con bolsa auto inflable por flujo (Bolsa), intubación endotraqueal (TET), masaje cardíaco, medicamentos).

8.9 Fallece en lugar de parto

FALLECE en LUGAR de PARTO	
no ☐	si ☐

Marcar con una (X) en SI cuando el neonato nació vivo (esfuerzo respiratorio, latidos cardíacos, latidos del cordón umbilical) pero falleció en la sala de partos; de lo contrario marcar con una (X) en NO.

8.10 Traslado

TRASLADO	
aloj. conj.	neona tolog.
☐	☐

Marcar con una (X) según corresponda:

- 1.-Alojamiento conjunto si el neonato permanece junto a su madre después del parto.
- 2.-Ingreso a la Unidad de Neonatología, ya sea Intensiva, Intermedia o Básica.

8.11 Atendió

ATENDIÓ	médico	obst.	enf.	auxil.	estud.	empir.	otro	Nombre
PARTO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
NEONATO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Marcar con una (X) la casilla que corresponda, se refiere al personal que atendió a la madre (PARTO) y al recién nacido (NEONATO), en la casilla que corresponda: (médico, obstetrix, enfermera, auxiliar, estudiante, empírica (partera), otro) y a continuación anotar el nombre completo.

8.12 Tipificación al recién nacido (RN)

Tipificación R.N.

Handwritten signatures and notes:
 CP. 70
 H. 10
 (Other illegible signatures and marks)

Conocer el grupo sanguíneo y el factor Rh, es fundamental en situaciones de emergencia en las que sea necesario transfusión o ante la presencia de ictericia neonatal. Existen cuatro grupos sanguíneos: A, B, AB y O. La diferencia entre ellos es la presencia o ausencia de antígenos en cada uno de los glóbulos rojos. Estos antígenos son proteínas de las células que provocan una respuesta inmune cuando detectan la presencia de otros antígenos que no tienen estos glóbulos rojos. Por esta razón, cuando se hace una transfusión es preciso que sea con aquel tipo de sangre que tenga sus mismos antígenos. De lo contrario, se podría producir una reacción de sensibilización al sistema inmune.

Anotar en el recuadro correspondiente el resultado del tipo de sangre del recién nacido.

8.13 Vitamina k

Vitamina K	
no	si
☐	☐

La deficiencia de vitamina K puede causar hemorragia en neonatos durante las primeras semanas de vida. Esto se conoce como enfermedad hemorrágica del recién nacido (EHRN). Esta enfermedad se agrupa en tres categorías: aparición temprana, aparición clásica y aparición tardía.

La aparición temprana ocurre dentro de las 24 horas posteriores al parto.

La aparición clásica ocurre en la primera semana posterior al nacimiento, los sitios de hemorragia frecuentes son el gastrointestinal, el nasal y los sitios de venopunción.

La aparición tardía ocurre entre la semana 2 y 12. Los sitios de hemorragia más frecuentes son el intracraneal, el gastrointestinal y los sitios de venopunción..

Generalmente, la vitamina K se administra como profilaxis después del nacimiento para la prevención de la EHRN. La vía de administración es intramuscular, en el muslo derecho.²³

Marcar con una (X) según corresponda (Si/No), si se aplicó o no la vitamina K al recién nacido.

8.14 Profilaxis ocular

Profilaxis Ocular	
no	si
☐	☐

Se recomienda la realización de la profilaxis oftálmica en la atención rutinaria. La profilaxis oftálmica reduce de forma drástica la incidencia de oftalmía gonocócica y la ceguera. Se recomienda colocar una dosis única de pomada oftálmica de eritromicina al 0,5% para la profilaxis oftálmica del recién nacido (RN). La solución de nitrato de plata puede producir conjuntivitis química transitoria en el recién nacido (RN), por lo que debe evitarse. El tiempo de administración de profilaxis oftálmica puede ampliarse hasta las cuatro horas tras el nacimiento¹⁰.

Marcar con una (X) según corresponda (Si/No), si se aplicó profilaxis ocular al recién nacido.

8.15 Método canguro

MÉTODO CANGURO	
Amerita	Se aplica
no	si
si	no

La aplicación de método canguro se recomienda exclusivamente para recién nacidos/as prematuros o de peso bajo que se encuentran **en rangos normales**, especialmente en aspectos de respiración, termorregulación y deglución.

Una vez adaptado a la vida extrauterina, el niño prematuro y su madre, inician el entrenamiento en el hospital, preparándose para la alimentación materna, el método canguro y el egreso. Cuando se autorice la salida, el neonato va a casa con su familia, permaneciendo en contacto directo piel a piel las 24 horas del día, en el pecho de su madre, de su padre u otro miembro de la familia capacitado, con lactancia materna exclusiva y con el compromiso de asistir a la consulta de seguimiento muy rigurosa, donde se valorará su desarrollo psicomotor, su visión, su audición y su crecimiento somático. Este seguimiento permite detectar desviaciones tempranamente y actuar rápidamente para evitar, hasta donde sea posible, la aparición de secuelas²⁴.

El registro de la variable se realiza de la siguiente manera:

En la columna **Amerita**:

- 1.-Marcar con una (X) en "no" si el/la RN es: (a término o tiene 2.500 g o más).
- 2.-Marcar con una (X) en "si" si el/la RN es: (prematuro o tiene PBN (Peso Bajo al nacer, menor o igual a 2.500 g).

Si el recién nacido (RN) amerita Método Canguro, en la columna de **Se aplica**:

- 1.-Marcar con una (X) en "si" cuando el/la recién nacido (RN) prematuro o Peso Bajo al Nacer fue atendido con método canguro mientras estuvo en el hospital.
- 2.-Marcar con una (X) en "no" cuando el/la recién nacido (RN) prematuro o PBN no fue atendido con método canguro mientras estuvo en el hospital.

8.16 Examen físico normal

NORMAL	
EXAMEN FÍSICO	no
	si

El examen físico tiene como objetivo asegurar que no existen signos de patologías importantes que requieran intervención e identificar anomalías congénitas de consideración.

Lo ideal es realizar el examen físico de un recién nacido desde su nacimiento, de la siguiente manera:

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "D. C.", "C.R.", "72", "H.F.C.", and "H.F.C."]

1.-En las primeras 4-6 horas de vida

Tiene como finalidad comprobar la adaptación cardiorespiratoria y neurológica inmediata del RN, así como controlar la termorregulación, la lactancia y el relacionamiento padres-RN.

2.-Al cumplir 12 horas de vida y al alta

Se realiza nuevamente el control del peso y un examen físico y neurológico ordenado y completo. Idealmente debe ser realizado en presencia de los padres, para resolver todas las dudas de éstos y al mismo tiempo observar la interacción de éstos con el recién nacido (RN). Informar a los padres sobre signos de alarma.

Marcar con una (X) según corresponda (Si/No), si al momento del examen físico realizado al neonato, si éste es normal o no.

8.17 Defectos congénitos

DEFECTOS CONGÉNITOS				
	no	menor	mayor	
CIE 10	☐	☐	☐	

Se entiende por malformación congénita mayor aquella capaz de producir la pérdida de la función del órgano correspondiente. Por ejemplo agenesia del pulgar.

Las malformaciones congénitas menores, al no provocar la pérdida de función y suelen ser de tipo estético. Por ejemplo: papiloma preauricular.

Marcar con una (X) la presencia de malformación congénita en el neonato, según corresponda (no, menor, mayor) y registrar en el recuadro correspondiente el código según la CIE-10 (4 dígitos).

8.18 Enfermedades

ninguna ☐ 1 ó más ☐				
CIE 10	☐	☐	☐	☐

Esta sección sirve para registrar otras enfermedades distintas a los defectos congénitos.

La Historia Clínica Materna Perinatal, incluye el espacio para registrar hasta 4 códigos CIE-10 (4 dígitos) del diagnóstico o patología del recién nacido y proporciona espacio para escribir el detalle del diagnóstico.

Existen dos variables de resumen: "Ninguna" (si no hubo patologías en el recién nacido desde el nacimiento hasta el alta) o 1 o más en caso contrario.

8.19 Tamizaje metabólico neonatal

TAMIZAJE METABÓLICO	
☐ Se realiza	☐ No se realiza
☐ n/a	

El Tamizaje Metabólico Neonatal es un programa del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, cuyo objetivo es la prevención de la discapacidad intelectual y la muerte precoz en los recién nacidos, mediante la detección temprana y manejo de errores del metabolismo.

Tamiza cuatro enfermedades:

Hiperplasia Suprarrenal
Hipotiroidismo
Galactosemia
Fenilcetonuria

Marcar con una (X) según corresponda (se realizó, no se realizó, n/a, no aplica ya que puede tratarse de una condición de alta del recién nacido, antes del 4to día, ante lo cual, no aplica realizar el tamizaje).

8.20 Tamizaje neonatal auditivo

TAMIZAJE AUDITIVO				
Pasa	OI	☐	OD	☐
No pasa	OI	☐	OD	☐
No se hace	☐			

El tamizaje auditivo neonatal es un estudio rápido y seguro que se realiza para detectar en forma precoz de la sordera en el recién nacido, esto permite una rápida acción para prevenir diversos tipos de sordera. Se lo realiza al momento del alta del recién nacido.

Si la madre durante el embarazo presentó enfermedades como rubéola, toxoplasmosis, citomegalovirus y herpes; y el recién nacido pesó menos de 1500 gramos o fue diagnosticado de ictericia o meningitis, el examen debe realizarse inmediatamente.

Marcar con una (X) el resultado de cada oído (pasa/no pasa) ó no se hace.

8.21 Vacuna hepatitis B

VACUNA Hepatitis B Dosis 0	
Se puso	☐
No se puso	☐

La hepatitis B es una infección vírica del hígado que puede dar lugar tanto a un cuadro agudo como a una enfermedad crónica. El virus se transmite por contacto con la sangre u

Handwritten signatures and stamps:
Amor...
7462
11/11/11
11/11/11
11/11/11

otros líquidos corporales de una persona infectada. Se estima que hay 240 millones de personas que padecen infección crónica por el virus de la hepatitis B (definidas como positivas al antígeno superficial del virus de la hepatitis B durante al menos seis meses).

La dosis inicial deberá ir seguida de dos o tres dosis para completar la serie primaria. En la mayoría de los casos se considera apropiada cualquiera de las dos opciones siguientes:

Tres dosis de la vacuna; la primera (monovalente) al nacer, y las dos subsiguientes (monovalentes o combinadas) al mismo tiempo que las dosis primera y tercera de la vacuna contra la difteria, la tos ferina y el tétanos (DTP); o cuatro dosis de la vacuna; la primera (monovalente) al nacer, y las tres subsiguientes (monovalentes o combinadas) al mismo tiempo que otras vacunas infantiles sistemáticas²⁵.

Marcar con una (X) según corresponda (se puso, no se puso) la vacuna contra hepatitis B.

8.22 Apego inmediato

APEGO INMEDIATO	
si	☐
no	☐

También llamado apego precoz, consiste en colocar al recién nacido sano desnudo en posición decúbito ventral sobre el torso desnudo de la madre piel con piel, apenas nace o poco tiempo después (dentro de la primera hora luego del nacimiento).

El contacto temprano piel a piel, produce la liberación de la oxitocina ocasionando un incremento de la temperatura de la piel de las mamas de la madre, proporcionando calor al recién nacido, antagoniza el efecto de lucha o huida, reduce la ansiedad materna reinstaura el vínculo madre e hijo, aumenta la tranquilidad y la receptividad social²⁶.

Marcar con una (X) según corresponda (Si/No), si se realizó o no el apego inmediato.

8.23 Meconio 1er día

Meconio 1 ^{er} día	
no	si
☐	☐
Lactancia Inmediata	
no	si
☐	☐

Normalmente la primera eliminación de meconio en el recién nacido se produce dentro de las primeras 24 horas de vida extrauterina. Puede ocurrir también antes de nacer en casos de sufrimiento fetal, por lo que el líquido amniótico aparece teñido o espeso por el meconio. Puede aparecer en el momento del expulsivo, pero lo habitual es que lo haga en las horas siguientes.

La falta de expulsión de meconio debe hacer pensar en alguna causa que altere el tránsito intestinal, lo primero que hay que descartar es la alimentación inadecuada, la atresia recto

anal o el íleo meconial, provocado por espesamiento de meconio en el que como causa de fondo está la fibrosis quística.

Otra patología que hay que descartar en los casos de falta o retraso en la eliminación de meconio es la enfermedad de Hirschsprung. En los casos de obstrucción intestinal baja hay además distensión abdominal. Es necesario hacer un estudio radiológico para certificar el diagnóstico, el tratamiento en este caso es quirúrgico²⁷.

Marcar con una (X) según corresponda (Si/No), si el neonato presentó meconio en el primer día de vida.

8.24 Lactancia inmediata

La lactancia materna en la primera hora de vida reanuda el vínculo entre la madre y su hijo.

Además la leche materna fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo, y protege al niño de las enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas. La lactancia materna exclusiva reduce la mortalidad del lactante por enfermedades frecuentes en la infancia, tales como la diarrea o la neumonía, y ayuda a una recuperación más rápida de las enfermedades.

Para que las madres puedan iniciar y mantener la lactancia materna exclusiva durante 6 meses, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recomiendan:

- Que la lactancia se **inicie** en la primera hora de vida; lactancia inmediata
- Que el lactante solo reciba leche materna, sin ningún otro alimento ni bebida, ni siquiera agua;
- Que la lactancia se haga a libre demanda, es decir, con la frecuencia que quiera el niño, tanto de día como de noche;
- Que no se utilicen biberones, tetinas ni chupetes.

Marcar con una (X) según corresponda (Si/No), si se realizó la lactancia materna inmediata, en la primera hora de vida.

Sección 9: Egreso del recién nacido

Objetivo: verificar las condiciones vitales en las que el recién nacido es egresado del establecimiento.

Esta sección está destinada al registro del momento del alta del recién nacido, ya sea recién nacido a término, como prematuro o de bajo peso, la condición del alta y el sitio de referencia

EGRESO RN		vivo ☐ fallece ☐ referencia ☐	Fallece durante la referencia	Fallece en el lugar de la referencia	ALIMENTO AL ALTA	DECUBITO SUPINO
hora	min	Nombre establecimiento	no ☐ si ☐	no ☐ si ☐	lact. excl. ☐	no ☐ si ☐
dia	mes		EDAD	<1 día	parcial ☐	BCG no ☐ si ☐
año			días completos	☐	artificial ☐	PESO AL EGRESO
Certificado Recién Nacido	C.C. / H.Cl.				leche humana ☐	g
Nombre Recién Nacido		Responsable egreso RN / nombres completos / sello				

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the number 76 and the text "H-4".

9.1 Egreso del recién nacido (RN)

Marcar con una (X) según corresponda: vivo, fallece, referencia.

Anotar la hora, minutos, día, mes, año y el nombre del establecimiento de referencia.

En caso de nacimiento de un niño/a vivo/a se debe llenar de la siguiente manera:

Si el niño/a nació vivo/a y sigue vivo/a al momento del alta, entonces EGRESO RN debe incluir la fecha y hora del alta, además marcar con una (X) el círculo correspondiente (vivo).

Si el niño/a nació vivo/a pero por alguna complicación requiere ser referido/a a otro establecimiento de salud, entonces el egreso RN debe incluir la fecha y hora de la referencia, además marcar con una (X) el círculo (referencia) y anotar el nombre del establecimiento de salud al que se refiere.

Si el niño/a nació vivo/a y muere, el egreso RN debe incluir la fecha y hora del fallecimiento, además marcar con una (X) el círculo amarillo (fallece). Si el fallecimiento ocurre fuera del lugar de nacimiento, debe anotarse claramente el nombre del otro establecimiento de salud.

En caso de ABORTO y de MUERTE FETAL, esta sección queda en blanco.

En caso de referencias, la Historia Clínica Materna Perinatal- HCMP "Formulario 051" incluye los siguientes datos:

Fallece durante o en lugar de referencia, marcar con una (X) según corresponda (Si/No).

Edad en días completos en que ocurrió el fallecimiento. Si la muerte se produce dentro de las primeras 24 horas marcar con una (X) el círculo (< 1 día).

Para los neonatos que no fueron referidos, este cuadro debe quedar en blanco.

9.2 Alimento al alta

Marcar con una (X) según corresponda, indicar el tipo de alimentación que el niño tiene al momento del alta:

Lactancia materna exclusiva (lact. excl.): el recién nacido ha recibido solamente leche materna y ningún otro líquido o leche artificial.

Lactancia no exclusiva (parcial): recibió leche materna y además líquida o leche artificial.

Leche artificial: leche de fórmula, sucedáneos de la leche materna.

Leche humana: corresponde a la administración de leche materna segura pasteurizada en un Banco de Leche Humana, a los recién nacidos que por su condición clínica (ejemplo: prematuros) o por condiciones maternas no pueden ser amamantados directamente de su propia madre.

9.3 Decúbito supino

La importancia de esta variable es crear conciencia de los peligros de dormir en decúbito prono y / o conceptos erróneos acerca de los riesgos de dormir en posición supina del recién nacido.

El síndrome de muerte súbita del lactante (SIDS) es la principal causa de muerte en los bebés de un mes a 12 meses de edad. Los bebés acostumbrados a dormir boca arriba que se

los coloca a dormir boca abajo tienen 18 veces más probabilidades de morir de síndrome de muerte súbita del lactante (SIDS) en comparación con bebés que son colocados a dormir boca arriba siempre.²⁸

Marcar con una (X) según corresponda (Si/No), si la madre ha recibido la información de colocarle al bebé boca arriba.

9.4 BCG

La vacuna BCG previene la diseminación hematógena a partir del foco primario, mostrando una protección del 80% para las formas de tuberculosis infantil más severas (meníngea y miliar), cuando la vacunación se realiza en el recién nacido.

Una dosis de 0.1ml ó 0.05 ml, por vía intradérmica en la parte media del músculo deltoides del brazo derecho. Aplicar a todos los recién nacidos (dentro de las 24 horas), en el primer contacto del niño(a) con los servicios de salud, hasta los 11 meses 29 días.

Fuente: Programa Ampliado de Inmunizaciones, Ministerio de Salud Pública.

Marcar con una (X) según corresponda (Si/No), si el neonato ha recibido o no la vacuna BCG antes del alta.

9.5 Peso al egreso

Anotar en el recuadro correspondiente el peso del recién nacido en gramos al momento del alta del establecimiento de salud.

9.6 Certificado recién nacido

Constituye un registro permanente y oficial de la existencia del niño. La inscripción del nacimiento **de una persona es un derecho**, lo cual reconoce la existencia de la misma ante la ley, establece los vínculos familiares del niño y recorre la trayectoria de los acontecimientos fundamentales en el vivir de un individuo, desde el nacimiento con vida hasta el matrimonio y la muerte.

Así como lo menciona la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No 684 de 04 de febrero del 2016.

"Art. 29.- Número Único de Identificación.- Al nacido vivo se le asignará un Número Único de Identificación (NUI) relacionado con un elemento biométrico de la persona, de tal manera que permita individualizar a la persona desde su nacimiento garantizando la identidad única, por lo que es obligación del Estado a través del órgano público encargado de la salud, establecimientos de salud públicos y privados, y de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, realizar las inscripciones de nacimientos de forma inmediata dentro del establecimiento de salud y sin que medie la solicitud del interesado(...)"

Anotar en el espacio correspondiente el número de certificado de nacimiento otorgado.

9.7 Cédula de identidad / historia clínica

Anotar en el recuadro correspondiente el número de la historia clínica ó la Cédula de identidad del recién nacido; en caso de no tener este dato asignar y anotar el código temporal según el **Acuerdo Ministerial No. 00004934**.

[Handwritten signatures and stamps in the bottom right corner, including a circular stamp with the number 78 and various initials.]

9.8 Nombre del recién nacido

Anotar en el recuadro correspondiente los apellidos de la madre si el nombre aún no ha sido elegido por los padres.

9.9 Responsable egreso del recién nacido (RN) / nombres completos / sello

Anotar en el recuadro correspondiente los nombres completos y el sello del médico responsable del alta del recién nacido (RN).

Sección 10: Egreso materno

Objetivo: verificar las condiciones vitales en las que la madre es egresada del establecimiento.

Esta sección está destinada al registro del momento del alta de la madre, su condición y el sitio de referencia.

EGRESO MATERNO						Fallece durante la referencia	Fallece en el lugar de la referencia
hora	min	día	mes	año	no ☐ sí ☐	no ☐ sí ☐	
					días completos desde el parto		
viva ☐ fallece ☐ referencia ☐							
Nombre del establecimiento							
Responsable egreso materno / nombres completos / sello							

10.1 Egreso materno

Marcar con una (X) según corresponda: viva, fallece, referencia.

Anotar el día, mes, año y el nombre del establecimiento de referencia.

- 1.-En los casos en que la madre vive al momento del alta, en el egreso materno se debe marcar con una (X) el círculo (viva), y anotar la fecha del alta (incluye la hora del alta).
- 2.-En los casos en que la madre es referida a otro servicio o institución diferente al establecimiento en donde se llenó la Historia Clínica Materna Perinatal, en el egreso materno se deberá establecer los mecanismos necesarios para tener conocimiento acerca de la evolución de su salud.
- 3.-En los casos en que la madre presentó alguna complicación y debe ser referida a otro establecimiento, en el egreso materno se debe incluir la fecha y hora de la referencia, además marcar con una (X) el círculo amarillo (referencia) y anotar el nombre del establecimiento al que se refirió a la madre.
- 4.-En los casos en los que la madre falleció en el establecimiento donde ocurrió el nacimiento, en el egreso materno se debe incluir la fecha, hora del fallecimiento y se debe marcar con una (X) el círculo amarillo (fallece).

Marcar con una (X) según corresponda (Si/No) y anotar el tiempo transcurrido desde el momento del parto o cesárea hasta el fallecimiento de la madre.

Para las madres que no fueron referidas se deja en blanco este espacio.

Sección 11: Anticoncepción

Objetivo: brindar a la embarazada la mejor información disponible sobre métodos anticonceptivos, con un lenguaje adecuado a su comprensión y su situación de una manera asertiva.

ANTICONCEPCIÓN			
		no	si
ASESORÍA		☐	☐
MÉTODO			
	pref.	acced.	
Barrera	☐	☐	DIU ☐
Hormonal	☐	☐	Natural ☐
Quirúrgico	☐	☐	Ninguno Otro ☐

11.1 Asesoría

Marcar con una (X) según corresponda (Si/No), si la madre recibió asesoría sobre anticoncepción antes del alta.

Este dato debe llenarse en toda madre que haya tenido un parto o aborto.

11.2 Método

Marcar con una (X) según corresponda el método preferido o accedido por la madre luego de la asesoría.

Se marcará **prefiere**, cuando la mujer recibe la asesoría y solamente realiza la elección pero no accede al método.

Se marcará **accede** cuando la Unidad de salud le haya dado asesoría y le provee el método anticonceptivo.

1.-**Barrera** (condón masculino, condón femenino).

2.-**Dispositivo Intrauterino (DIU).**

3.-**Hormonales:** (Implante subdérmico anticonceptivo hormonal, orales combinados composición hormonal progesterona y estrógenos, orales para progesterona anticonceptivo hormonal para mujeres en periodo de lactancia, inyectable (composición hormonal progesterona y estrógenos)

4.-**Método natural:** método de día fijo, método de amenorrea por lactancia, abstinencia periódica, ritmo, Billings, entre otros.

5.-**Quirúrgico:** (Ligadura tubárica).

6.-**Ninguno:** Marcar con una (X) esta opción, cuando la mujer no ha elegido ningún método anticonceptivo.

7.-**Otro**

11.3 Responsable egreso materno / nombres completos / sello

Anotar en el recuadro correspondiente los nombres completos y el sello del médico responsable del alta de la madre.

[Handwritten signatures and stamps in the bottom right corner, including a circular stamp with the number 80 and the letters MEC.]

Sección 12: Detalles en partograma

La atención integral de la madre embarazada en trabajo de parto requiere del conocimiento de elementos anatómicos, funcionales, clínicos, psicológicos, sociales y culturales, que intervienen en el proceso del nacimiento.

Aunque el proceso de nacer es fisiológico, no está exento de riesgos tanto para la madre como para el feto, debido a circunstancias particulares que deben ser identificadas durante el trabajo de parto. El médico debe garantizar, con su juicio clínico, que el parto vaginal es factible, y por tanto se puede conducir un trabajo de parto, para lo cual se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. Identificar la historia clínica del trabajo de parto con nombres y apellidos, fecha y número de historia.
2. Utilizar la tabla ubicada en la parte inferior derecha del partograma, para registrar las evaluaciones clínicas desde el ingreso de la embarazada al hospital, tanto durante el período previo a la fase activa del trabajo de parto como durante este. Debe escribirse la hora de evaluación en cada columna y de manera consecutiva siguiendo las letras desde la "a" hasta la "p". Las horas registradas en esta tabla, no tienen que coincidir necesariamente con las horas consignadas en la tabla del partograma, pues cada que se evalúa la embarazada no se realiza un tacto vaginal.

Esta parte del partograma debe ser diligenciada cada que se evalúe a la madre embarazada por cualquier miembro del equipo de salud (médico, profesional de enfermería ó auxiliar de enfermería).

Las madres embarazadas de bajo riesgo se deben evaluar, como mínimo, cada 30 minutos y las de alto riesgo cada 15 minutos o con mayor frecuencia si se considera pertinente. Estas evaluaciones deben incluir la evaluación de la FCF, posición materna, pulso materno, calidad de la actividad uterina (duración, frecuencia e intensidad de las contracciones) y localización del dolor.

PARTOGRAMA

POSICIÓN	VERT.	HORIZONTAL
PARADO	TÓCICO	MULTIPARAS
MEMBRANAS	INTÉ-GRAS	INTÉ-GRAS

0:15	0:15	0:05	0:30	0:20
0:25	0:25	0:10	0:35	0:35
0:35	0:40	0:25	0:40	0:50
1:00	0:55	0:35	1:00	1:05
1:15	1:25	1:00	1:30	1:25
2:10	2:30	2:30	3:15	2:30

VALORES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CURVAS DE ALZATA
(en horas) p 10

FRECUENCIA CARDÍACA FETAL	☐
PLANOS DE HODGE Y	☐
VARIEDAD DE POSICIÓN	☐
DILATACIÓN CERVICAL	☐
RUPTURA ESPONTÁNEA MEMB.	☐
RUPTURA ARTIFICIAL MEMB.	☐
INTENSIDAD	☐
LOCALIZACIÓN	☐
Fuente	SP
Motivación	SP
Dilatación	SP
Intensidad	SP
Localización	SP

FRECUENCIA CARDÍACA FETAL	☐
Dilatación tipo I	☐
Dilatación tipo II	☐
Dilatación tipo III	☐
Dilatación tipo IV	☐
Dilatación tipo V	☐
Dilatación tipo VI	☐
Dilatación tipo VII	☐
Dilatación tipo VIII	☐
Dilatación tipo IX	☐
Dilatación tipo X	☐
Dilatación tipo XI	☐
Dilatación tipo XII	☐
Dilatación tipo XIII	☐
Dilatación tipo XIV	☐
Dilatación tipo XV	☐
Dilatación tipo XVI	☐
Dilatación tipo XVII	☐
Dilatación tipo XVIII	☐
Dilatación tipo XIX	☐
Dilatación tipo XX	☐
Dilatación tipo XXI	☐
Dilatación tipo XXII	☐
Dilatación tipo XXIII	☐
Dilatación tipo XXIV	☐
Dilatación tipo XXV	☐
Dilatación tipo XXVI	☐
Dilatación tipo XXVII	☐
Dilatación tipo XXVIII	☐
Dilatación tipo XXIX	☐
Dilatación tipo XXX	☐

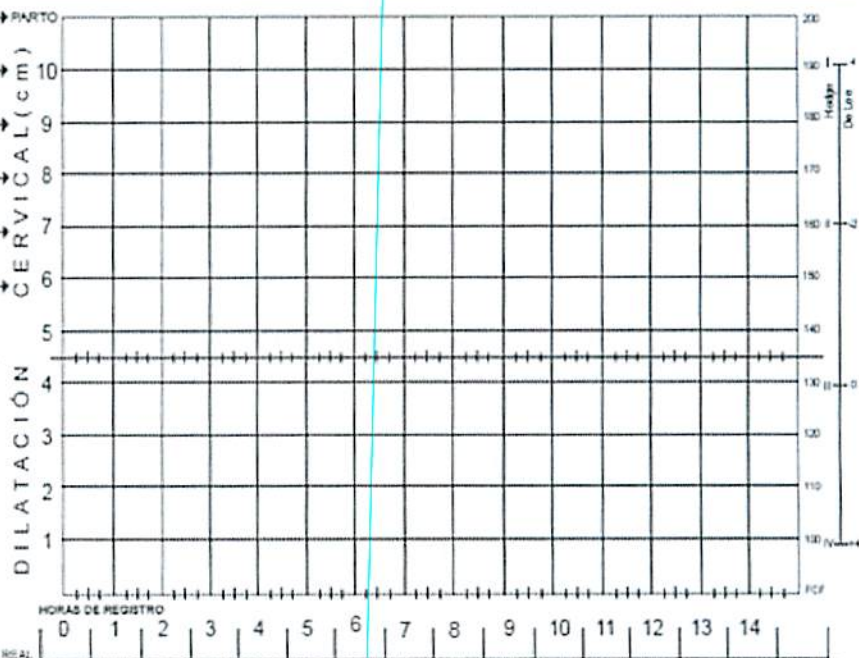
REFERENCIAS
SCHWARTZ R. DIAZ A.G.
MARTO R. CLAP

C.C. / H.C.I.

APELLIDO PATERNO

MATERNO

NOMBRES



HORA REAL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HORA	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	p
POSICIÓN MATERNA															
TENSIÓN ARTERIAL															
PULSO MATERNO															
FRECUENCIA CARDÍACA FETAL															
DURACIÓN CONTRACCIONES															
FREC. CONTRACCIONES															
DOLOR / Localiz. / Inten.															

3. En la parte inferior izquierda del partograma, se encuentran las convenciones propuestas para el diligenciamiento del mismo. Incluye los planos pélvicos y la variedad de posición, la dilatación, el estado de las membranas, la intensidad de la contracción y su localización, la frecuencia cardiaca fetal, y la posición materna durante el trabajo de parto.

Estas convenciones se emplean para diligenciar las tablas de evaluación clínica y de dilatación y descenso.

Handwritten signatures and notes at the bottom right of the page, including "82" and "H-EC".

PARTOGRAMA						C.C./H.C.L.										DIA MES AÑO					
POSICIÓN: VERT. HORIZONTAL PRESENTACIÓN: CEFÁLICA, BASTANTE, BASTANTE ROTACIÓN: ROTAS, ROTAS, ROTAS, ROTAS, ROTAS						APELLIDO PATERNO: _____ MATERNO: _____ NOMBRES: _____															
VALORES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CURVAS DE ALERTA (en centímetros) 0-15 0-15 0-25 0-20 0-20 0-25 0-25 0-10 0-35 0-35 0-35 0-40 0-25 0-40 0-50 1-30 0-55 0-35 1-20 1-35 1-15 1-25 1-20 1-30 1-35 2-10 2-30 2-30 2-15 2-30						PARTO CERVICAL (cm) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0															
LINEA DE BASE DESDE LA QUE SE LEVA LA C.C. DE ALERTA						DILATACIÓN HORAS DE REGISTRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14															
REFERENCIAS FRECUENCIA CARDÍACA FETAL PLANOS DE ROTACIÓN Y VELOCIDAD DE POSICIÓN DILATACIÓN CERVICAL RUPTURA ESPONTÁNEA MEMBRANAS RUPTURA ARTIFICIAL MEMBRANAS INTENSIDAD LOCALIZACIÓN Fuerza: ... Dirección: ... Ritmo: ... Dirección: ... Duración: ... Dirección: ... En la parte: ... Dirección: ...						HORAS REAL a b c d e f g h i j k l m n o p															

4. En la parte superior derecha se grafica la curva de dilatación cervical, las de alerta y de descenso de la cabeza fetal. La gráfica de la dilatación cervical solamente se debe iniciar cuando el embarazado este en la fase activa del trabajo de parto, es decir, cuando la dilatación cervical alcance los 4-5 cm y exista simultáneamente buena actividad uterina, tanto en frecuencia como en intensidad. Los dos aspectos anteriores son fundamentales para no cometer el error de graficar la fase latente del trabajo de parto que puede llevar a medición y decisiones inadecuadas.

5. En el borde inferior de la tabla están las "horas de registro" del trabajo de parto activo desde las cero horas hasta las catorce. Cada segmento corresponde a una hora, dividida en cuatro porciones de quince minutos. Inmediatamente debajo de la línea de "horas de registro" están las casillas para registrar la "hora real", es decir la hora en que se inicia la curva de dilatación cervical, y las siguientes horas hasta el parto. Las "horas reales" de evaluación de la dilatación cervical usualmente no coinciden con las de evaluación clínica. Si se considera necesario relacionar la evaluación clínica con la de dilatación, se escribe la letra que aparece en la tabla de evaluación clínica correspondiente en el cajón respectivo de la "hora real".

PARTOGRAMA

C.C. / H.C.I.

DIA MES AÑO

APELLIDO PATERNO
 MATERNO
 NOMBRES

POSICIÓN	VERT.		HORIZONTAL	
	TODA	MULTÍPARA	MULTÍPARA	MULTÍPARA
MEMBRANAS	INTÉ-GRAS	INTÉ-GRAS	ROTA	ROTA

VALORES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CURVAS DE ALERTA (en horas)

0:15	0:15	0:25	0:30	0:20
0:25	0:25	0:10	0:35	0:35
0:35	0:40	0:25	0:40	0:50
1:00	0:55	0:35	1:00	1:05
1:15	1:25	1:00	1:30	1:25
2:10	2:30	2:30	3:15	2:30

LÍNEA DE BASE DESDE LA CUI SE INICIA LA CURVA DE ALERTA

DILATACIÓN (cm) CERVICAL (cm)

PARTO 10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1

130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200

0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14

a
 b
 c
 d
 e
 f
 g
 h
 i
 j
 k
 l
 m
 n
 o
 p

FRECUENCIA CARDÍACA FETAL
 PLANOS DE HODGE Y
 VARIACIÓN DE POSICIÓN
 DILATACIÓN CERVICAL
 RUPTURA ESPONTÁNEA MEMB.
 RUPTURA ARTIFICIAL MEMB.
 INTERSIDAD LOCALIZACIÓN
 Feto ☐ Superior ☐ SP
 Material ☐ Saco ☐ S
 Gird ☐ Cerebros ☐ S
 No se aplica ☐ Juntos ☐ A
 FRECUENCIA CARDÍACA FETAL
 Tipo tipo I
 (Discrepancia) prenatado I
 Tipo tipo II
 (Discrepancia) prenatal
 Tipo variable
 (Discrepancia) prenatal
 Tipo variable
 (Discrepancia) prenatal
 POSICIÓN MATERNA
 Lax. deprimida
 Lax. deprimida
 Dorsal
 Semientendida
 Sentada
 Parada o caminando
 PC
 SCHWARTZ, R. GUZMÁN,
 NÚMERO 1 CLAP

HORAS DE REGISTRO
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 HORA REAL
 a b c d e f g h i j k l m n o p

POSICIÓN MATERNA
 TENDENCIA MATERNA
 PULSO MATERNO
 FRECUENCIA CARDÍACA FETAL
 DURACIÓN CONTRACCIONES
 FREC. CONTRACCIONES
 DOLOR / Lumbos / Bazo

6. El partograma tiene una línea de base, señalada con una flecha, a partir de la cual se inicia la construcción de las curvas de alerta.

7. Para construir la "curva de alerta" se determina el punto de partida sobre la línea de base, luego se buscan los tiempos en la parte superior izquierda para construir la curva de alerta.

Los tiempos a emplear se eligen de acuerdo a la paridad, la posición de la embarazada durante el trabajo de parto y el estado de las membranas.

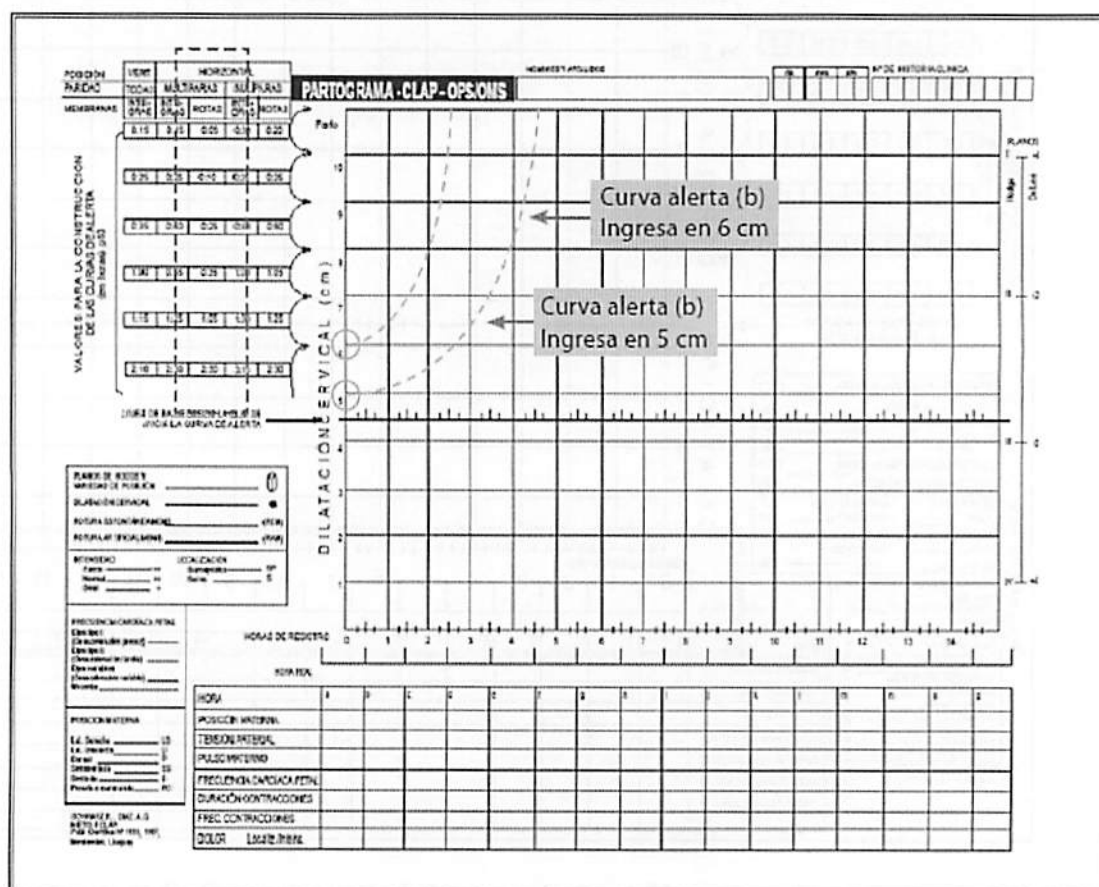
Si la embarazada es múltipara, tiene las membranas íntegras, y esta acostada, los tiempos a utilizar para construir la curva de alarma son los que corresponden a estas características. Las flechas indican el tiempo que se demora una embarazada determinada en pasar de un centímetro a otro.

8. Para construir la curva de alerta se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

Si la madre embarazada ingresa en 5 cm. de dilatación o más iniciar la curva de alerta en el punto que indica la dilatación correspondiente. El ejemplo muestra como se construyen las curvas de alarma para una embarazada múltipara con membranas rotas que ingresa en 5 cm de dilatación y otra que ingresa en 6 cm.

84
 C.P.
 HPC
 111

Sí se inicia el registro gráfico por debajo de la línea de base (antes de 4,5 cm de dilatación) se debe trazar una línea recta que una los puntos de la dilatación por debajo de la línea de base y el siguiente que esté por encima de la misma y construir la curva de alerta desde el punto donde la línea recta intercepta la línea de base.



9. Para construir la curva de descenso de la presentación (estación) se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

Emplee la línea del extremo derecho del partograma identificada como “planos”. Usted puede emplear los planos de Hodge o los de DeLee. Si usted usa la clasificación por tercios de pelvis, divida en tres partes iguales la porción de la línea por encima y por debajo del cero, así quedarán los planos de -1, -2 y -3 por encima del cero y de +1, +2 y +3 por debajo del cero.

Emplee el icono denominado “planos de Hodge y variedad de posición” para graficar el descenso de la presentación fetal

8. Abreviaturas

Edad Gestacional	(EG)
Fecha de la Última Menstruación	(FUM)
Anticuerpos Fluorescentes Antitreponema	(FTA)
Dispositivo Intrauterino	(DIU)
Centro Latinoamericano de Perinatología	(CLAP)
Organización Mundial de la Salud	(OMS)
Salud de la Mujer y Reproductiva	(SMR)
Historia Clínica Materna Perinatal	(HCMP)
Ministerio de Salud Pública	(MSP)
Recién Nacido Prematuro	(RNPT)
Bajo Peso al Nacer	(BPN)
Retardo de Crecimiento Intrauterino	(RCIU)
Pequeño para Edad Gestacional	(PEG)
Infección Respiratoria Aguda	(IRA)
Unidad de Cuidados Intensivos	(UCI)
Presión parcial de oxígeno	(PaO ₂)
Fracción inspirada de oxígeno	(FiO ₂)
Litro	(L)
Decilitro	(dL)
Recién Nacido	(RN)
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia	(UNICEF)
Bacilo de Calmette y Guérin	(BCG)
Síndrome muerte súbita del lactante	(SIDS)
Enfermedad Hemorrágica del recién nacido	(EHRN)
Difteria, tosferina, tétanos	(DTP)
Método Canguro	(MC)
Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica	(SIRS)

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller ones, some with dates like 86 and 11/11.

9. Referencias, instrumento original

Benson J. Evaluating Abortion-care Programs: Old Challenges, New Directions Studies in Family Planning Vol. 36 Issue 3 Page 189 September 2005.

CDC 2001. Revised Guidelines for HIV counseling, testing and referral and Revised recommendations for HIV Screening of Pregnant Women. MMWR 50(RR-19).

CDC 2006. Intimate Partner Violence During Pregnancy: A guide for Clinicians. www.cdc.gov/nccdphp/drh/violence/ipvdp.htm. Last accessed on Sept 30, 2006.

Crowther CA, Thomas N, Middleton P, Chua M, Esposito M. Treating periodontal disease for preventing preterm birth in pregnant women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: CD005297. DOI: 10.1002/14651858.CD005297.

Díaz AG, Schwarcz R, Díaz Rosello JL, et al. Sistema Informático Perinatal. Montevideo 1993. Publicación Científica CLAP 1203.

Dyson L, McCormick F, Renfrew MJ. Interventions for Promoting the initiation of breastfeeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005.

Faúndes A, Fiala C, Tang OS, Velasco A. Misoprostol for the termination of pregnancy up to 12 completed weeks of pregnancy. Int J Gynaecol Obstet. 2007 Dec;99 Suppl 2: S172-7. Epub 2007 Oct 24. Review.

Fescina R, De Mucio B, Díaz Rosello JL. Salud Sexual y Reproductiva. Guía para el continuo de atención de la mujer y el recién nacido. Focalizada en APS. Montevideo 2007. Publicación Científica CLAP/SMR 1562.

FLASOG. Uso de Misoprostol en Obstetricia y Ginecología. Faúndes A, editor. Segunda edición, Marzo 2007.

Gagnon AJ. Individual or group antenatal education for childbirth/parenthood. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 4. Art. No.: CD002869. DOI: 10.1002/14651858.CD002869.

Gómez Ponce de León R, Mañibo MA, Mañibo MB. 2007 COMPAC: Una herramienta para evaluar y mejorar la calidad de atención de las mujeres en situaciones de aborto. Chapel Hill, Carolina del Norte: Ipas.

Grosse S, Boyle C, Kenneson A, Khoury M, Wilfond B (2005) From Public Health Emergency to Public Health Service: The Implications of Evolving Criteria for Newborn Screening Panels. <http://www.cdc.gov/genomics/activities/publications/newborn.htm> Accessed on October 23, 2006.

Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr G J, Sakala C. Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 3. Art. No.: CD003766. DOI: 10.1002/14651858.CD003766.

Huapaya V. InfoAPA and EvalAPA: Subsistema de información sobre APA. Chapel Hill, NC, Ipas. 2002.

McDonald SJ, Abbott JM. Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes.(Protocol)

Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD004074. DOI: 10.1002/14651858.CD004074.

Organización Panamericana de la Salud. Plan Regional de VIH/ITS para el sector salud 2006-2015.Unidad de VIH/Sida. Washington DC: OPS, 2005.

Organización Panamericana de la Salud. Consulta sobre Enfermedad de Chagas Congénita,su epidemiología y manejo (OPS/DPC/CD/301/04). Unidad de Enfermedades Transmisibles Área de Prevención y Control de Enfermedades (OPS/AD/DPC/CD) y CLAP. Montevideo: OPS, 2004 .

Organización Panamericana de la Salud. Grupo Étnico y Salud. 37 sesión del subcomité de planificación y programación del comité ejecutivo (SPP37/10). Washington DC: OPS, 2003.

Organización Panamericana de la Salud. Infecciones de transmisión sexual y otras infecciones del tractoreproductivo. Una guía para la práctica básica. Departamento de Salud Reproductiva e Investigación.Washington DC: OPS, 2005.

Organización Panamericana de la Salud. Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades yProblemas Relacionados con la Salud. CIE-10. Décima Revisión. Washington DC: OPS, 1995.

Padilla K, McNaughton L, Gómez R. Un diagnóstico nacional de la atención postaborto. Nicaragua: Ipas, 2003.

Pena-RosasJP,ViteriFE.2006.Effects of routine oral iron supplementation with or without folic acid for women during pregnancy.Cochrane database of Systematic Review Issue 3. Art No.: CD004736. DOI:10.1002/14651858.CD004736.pub2.

Rabe H, Reynolds G, Diaz-Rossello J.Early versus delayed umbilical cord clamping in preterm infants.Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 4. Art. No.: CD003248. DOI: 10.1002/14651858. CD003248.pub2.

RobertsD,DalzielS.Corticosteroides prenatales para la aceleración de la maduración del pulmón fetal enmujeres con riesgo de parto prematuro(RevisiónCochranetraducida).En: La Biblioteca Cochrane Plus,2007 Número 1. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: <http://www.update-software.com>. (Traducida de The Cochrane Library, 2007 Issue 1.Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).

Shaw D. Misoprostol for reproductive health: Dosage recommendations. Int J Gynaecol Obstet. 2007 Dec;99Suppl 2:S155. Epub 2007 Oct 24.

Schwarz R, Díaz AG, Fescina RH, et al. Historia Clínica Perinatal Simplificada. Bol Oficina Sanit Panam.1983;95(2):163-172.

Valderrama J. Eliminación de la sífilis congénita en América Latina y el Caribe: marco de referencia para su implementación. Washington, DC: OPS, 2005. (Internet) <http://www.paho.org/Spanish/AD/FCH/AI/EliminaSifilisLAC.pdf> Último acceso 23 de marzo de 2007.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "CP de 88" and "HCC".

WHO 2005. Report of a WHO technical consultation on Birth Spacing. Department of Making Pregnancy Safer and Reproductive Health and Research.

WHO 2006. Standards for Maternal and Neonatal Care. Department Making Pregnancy Safer. 2006.

WHO 2006. Comprehensive Cervical Cancer Control: A guide to essential practice.

WHO 2002. WHO antenatal Care Randomized Trial: Manual for the Implementation of the new model.

WHO 1993. Breastfeeding Counseling: A training course. WHO/CDR/93.4 UNICEF/NUT/93.2

Referencias adaptación

1. Asamblea Nacional, Constitución de la República del Ecuador. Ecuador. 2008
2. Ministerio de Salud Pública. Dirección Nacional de Interculturalidad, Derecho y Participación Social en Salud. Autoidentificación étnica es un derecho (Rotafolio), MSP, 2015, Quito Ecuador.
- 3 Ley Orgánica de Educación Superior, Ecuador, Octubre, 2010.
4. Ministerio de Salud Pública. Guía de práctica clínica, diagnóstico y tratamiento del aborto espontáneo, incompleto, diferido y recurrente; Pág. 15 MSP; 2013.
- 5 Ministerio de Salud Pública. Guía de Práctica Clínica (Alimentación y Nutrición de la mujer gestante y de la madre en período de lactancia). MSP, 2014
6. Guías para el Continuo de Atención de la Mujer y el Recién nacido focalizada en APS. CLAP/SMR. Centro Latinoamericano de Perinatología. Publicación Científica N° 1577-2011
7. Ministerio de Salud Pública. Guía de Práctica Clínica Control Prenatal (GPC), MSP, 2015
8. Diagnostico y tratamiento de diabetes en el embarazo (pregestacional y gestacional, MSP, 2014.
- 9 . Ministerio de Salud Pública. Guía de Práctica Clínica Trastornos Hipertensivos del Embarazo (GPC), MSP, 2013.
- 10 Alvarado Rosa, A. M. (2012). Manejo del Triage Obstétrico y Código Mater en el estado de México. Enfermería Universitaria ENEO – UNAM , Vol 9. Año. 9.No. 2 Abril-Junio 2012.
- 11 Tejada Pérez Paúl, Cohen Aaron, Font Arreaza Ingrid J, Bermúdez Carlos, Schuitemaker Requena Juan B. Modificaciones fisiológicas del embarazo e implicaciones farmacológicas: maternas, fetales y neonatales. Rev Obstet Ginecol Venez [revista en la

Internet]. 2007 Dic [citado 2015 Ago 12] ; 67(4): 246- 267. Disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0048-77322007000400006&lng=es

12. Ministerio de Salud Pública. Guía de Práctica Clínica. Atención del trabajo parto, parto y postparto inmediato, MSP, 2014.

13. Liljestrand J. Episiotomía en el parto vaginal: Comentario de la BSR (última revisión: 20 de octubre de 2003). La Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS; Ginebra: Organización Mundial de la Salud. 2003. Disponible en http://apps.who.int/rhl/pregnancy_childbirth/childbirth/2nd_stage/jlcom/es/

14. Ministerio de Salud Pública. Norma y Protocolo Materno, 2008.

15. OPS, Plan de Acción para acelerar la reducción de la mortalidad materna y morbilidad materna grave, Estrategia de monitoreo y evaluación, Publicación Científica CLAP/SMR 1593, 2012.

16 Ministerio de Salud Pública, Norma y Protocolo Neonatal, 2008.

17 Curvas de peso al nacer, Nora E. Montoya-Restrepo y Juan C. Correa-Morales, Rev. salud pública. 9 (1):1-10, 2007.

18 Mediciones antropométricas del neonato, Dra. Cristina Cárdenas-López, Dra. Karime Haua-Navarro, Dra. Araceli Suverza-Fernández, M. en C. Otilia Perichart-Perera, Área de Nutrición Clínica, Dirección de Investigación, Instituto Nacional de Perinatología, D.F., México, Fecha de aprobación: 22-04-2005.

19 Manual de atención neonatal, . Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Dirección de Salud Integral de Niñez y Adolescencia, Paraguay, 2011.

20 Ayudar a los neonatos a respirar, Cuaderno de Estudio, Academia Americana de Pediatría, 2011.

21 Libro de texto de Reanimación Neonatal, Academia Americana de Pediatría y la Asociación Americana del Corazón, Sexta edición, 2011.

22 Protocolo Diagnostico Terapéuticos de la Asociación Española de Pediatría: Neonatología, capítulo 13, 2008.

23 Puckett RM, Offringa M. Profilaxis con vitamina K para la hemorragia por deficiencia de vitamina K en neonatos. Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas 2007, Número 4, artículo n.º: CD002776. DOI: 10.1002/14651858. CD002776.

24 Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Ministerio de la Protección Social República de Colombia. Lineamientos técnicos para la implementación de programas madre canguro en Colombia.

25 Organización Mundial de la Salud, Hepatitis B, Nota descriptiva N°204 Julio de 2015.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "omel", "90", and "HIC"]

26 Moore ER, Anderson GC, Bergman N. Contacto temprano piel a piel entre las madres y sus recién nacidos sanos. Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas 2007, Issue 3. No.: CD003519. DOI: 10.1002/14651858.CD003519.pub2.

27 Neonatología, Julio Nazer H, Rodrigo Ramírez F. Santiago de Chile, 2003.

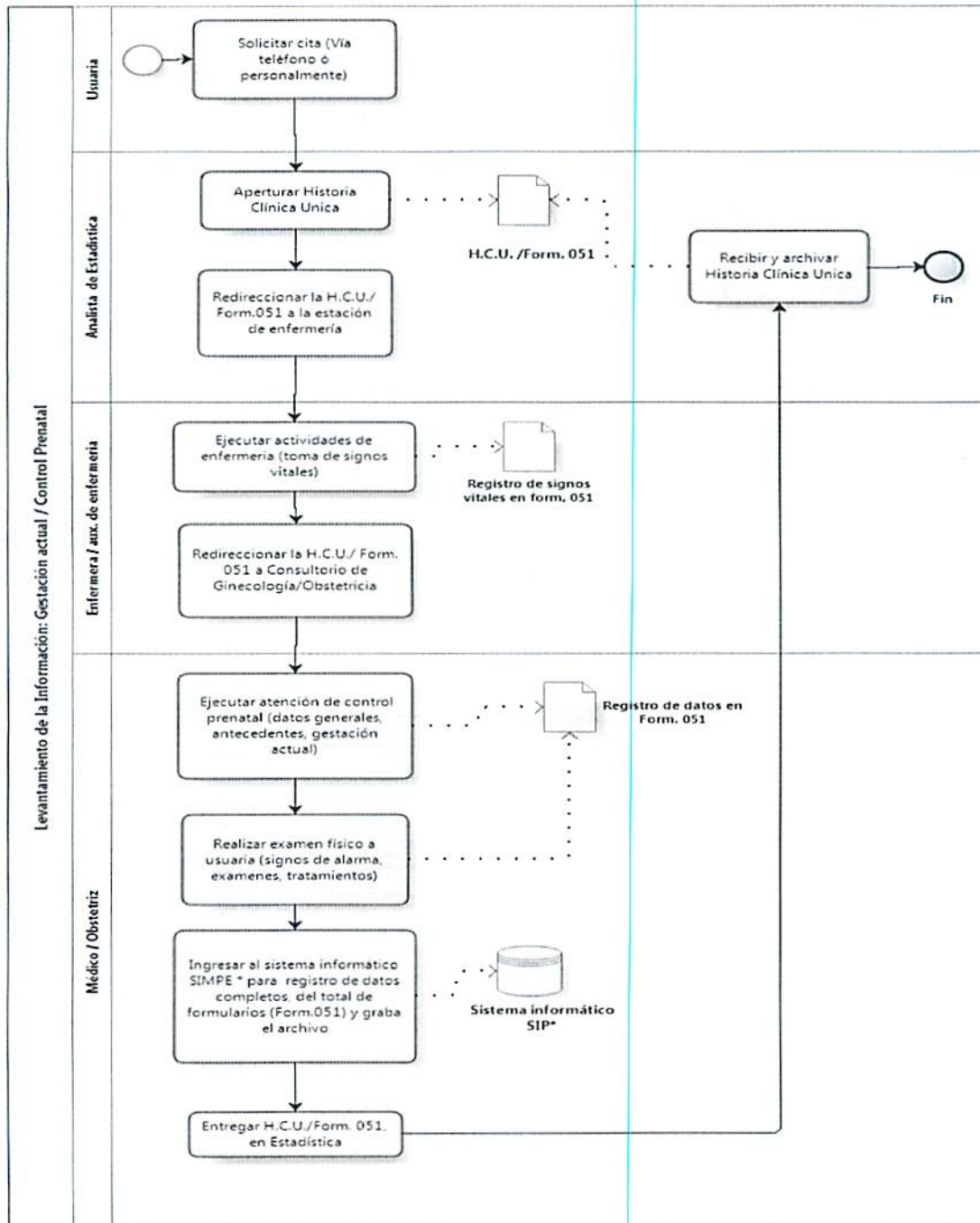
28 Ayuda para reducir el riesgo de síndrome de muerte súbita en el lactante, Academia Americana de Pediatría,

<http://www.healthychildcare.org/PDF/ParentsGuideSleepSPAN2011.pdf>

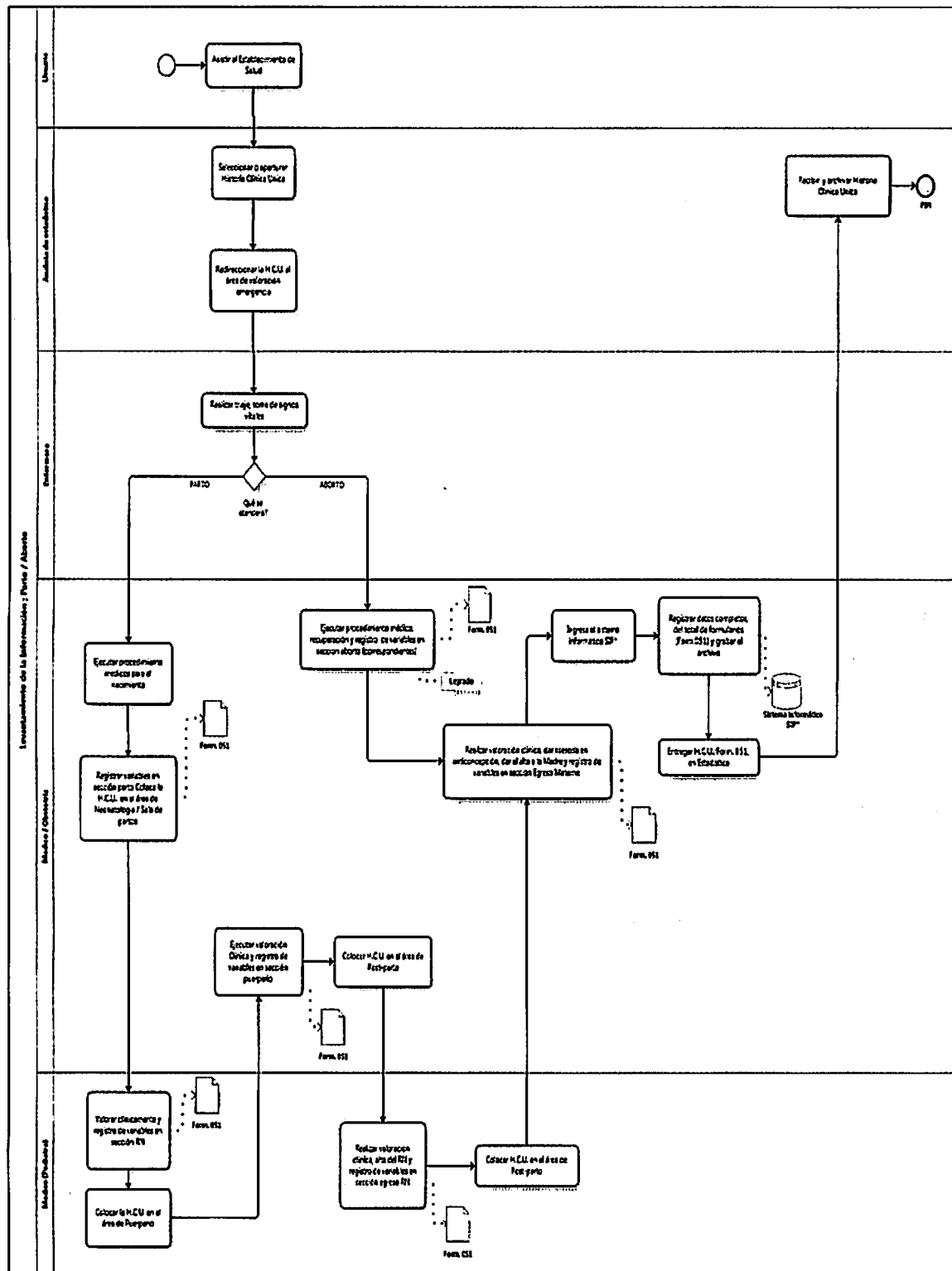
29 Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles - Página 9, Número único de identificación.

30 Registro del nacimiento, el derecho a tener derechos, Unicef, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Innocenti Digest n° 9, Florencia Italia, marzo 2002.

Anexo1. Levantamiento de información gestación actual



Anexo 2. Levantamiento de información parto/aborto



Anexo 3

HISTORIA CLÍNICA MATERNA PERINATAL - MSP

DATOS GENERALES

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Provincia: _____ Municipio: _____ Fecha de nacimiento: _____ Edad: _____ Sexo: _____

ANTECEDENTES

Familiares: _____ Antecedentes personales: _____

GESTACIÓN ACTUAL

Último embarazo: _____ Embarazo planificado: _____

ABORTO

Fecha de ingreso: _____ Fecha de parto: _____

CONSEJERÍA PRENATAL

Control prenatal: _____

POSTPARTO

Estado de salud: _____

COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS

Complicaciones obstétricas: _____

OTROS DATOS

Trastornos mentales: _____ Trastornos físicos: _____

ADAPTADO DE LA HISTORIA CLÍNICA PERINATAL BASE CLAP - OPMSP

PARTOGRAMA

C.C. / H.CU.

DIA MES AÑO

POSICIÓN	VERT.	HORIZONTAL
PARIDAD	TODAS	MULTIPARAS
MEMBRANAS	INTE-GRAS	INTE-GRAS

APELLIDO PATERNO

MATERNO

NOMBRES

VALORES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CURVAS DE ALERTA (en horas) p10

0.15	0.15	0.05	0.30	0.20
0.25	0.25	0.10	0.35	0.35
0.35	0.40	0.25	0.40	0.50
1.00	0.55	0.35	1.00	1.05
1.15	1.25	1.00	1.30	1.25
2.10	2.30	2.30	3.15	2.30

LINEA DE BASE DESDE LA QUE SE INICIA LA CURVA DE ALERTA

DILATACIÓN CERVICAL (cm)

HORAS DE REGISTRO

HORA REAL

REFERENCIAS

FRECUENCIA CARDÍACA FETAL ☐

PLANOS DE HODGE Y VARIEDAD DE POSICIÓN ☐

DILATACIÓN CERVICAL ☐

RUPTURA ESPONTÁNEA MEME. (PEM) ☐

RUPTURA ARTIFICIAL MEME. (RAM) ☐

INTENSIDAD LOCALIZACIÓN

Fuerte *** Surcubito DP

Modera ** Saco S

Debil * Contracciones

No o pocas Uterinas ▲

FRECUENCIA CARDÍACA FETAL

Dips tipo I (Desaceleración precoz) I

Dips tipo II (Desaceleración tardía) II

Dips variables (Desaceleración variable) V

Meconio M

POSICIÓN MATERNA

Lat. derecha LD

Lat. izquierda LI

Dorsal D

Semisentada SS

Enfada E

Parada o combinada PC

SCHWARTZ, R. DIAZ, A. G., NIETO, F. CLAP

HORA	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
POSICIÓN MATERNA																
TENSION ARTERIAL																
PULSO MATERNO																
FRECUENCIA CARDÍACA FETAL																
DURACIÓN CONTRACCIONES																
FREC. CONTRACCIONES																
DOLOR Localiz./intens.																

CRITERIOS CLÍNICOS/DISFUNCIÓN ÓRGANO-SISTEMA		LABORATORIO		INTERVENCIONES	
Cardiovascular: si no	Renal: si no	Laboratorio: si no sí	Administración continua de agentes vasodiladores: si no	Insuficiencia y ventilación no relacionada con la anestesia: si no	Administración > 3 vol. de hemoderivados: si no
Shock	Oliguria resistente a líquidos diuresis	Plaquetas < 50000 per ml	Quéiles		
Falta cardíaca	Hematológico/coagulación: Alteraciones de la coagulación	Creatinina > 300 micromoles/l 3.6 mg/dl	Insuficiencia y ventilación no relacionada con la anestesia: si no	Administración > 3 vol. de hemoderivados: si no	Diálisis en caso de IRA
Hepático	Neurológico: Coma	Bilirrubina > 100 micromoles/l 5.8 mg/dl	Administración > 3 vol. de hemoderivados: si no	Ingreso de UCI > 7 días	Histerectomía
Intercambio en preclampsia	Neurológico: Convulsiones	pH < 7.1	Administración > 3 vol. de hemoderivados: si no	Ingreso de UCI > 7 días	Histerectomía
Respiratorio: Córnea aguda	Neurológico: Convulsiones	Po2 < 90% p1 hora	Administración > 3 vol. de hemoderivados: si no	Ingreso de UCI > 7 días	Histerectomía
Respiración pobre (apnoea)	Neurológico: Convulsiones	Po2/FiO2 < 200 mmHg	Administración > 3 vol. de hemoderivados: si no	Ingreso de UCI > 7 días	Histerectomía
Toupetes severos FR > 40ppm	Neurológico: Convulsiones	Lactato > 5 mmol/l o 45 mg/dl	Administración > 3 vol. de hemoderivados: si no	Ingreso de UCI > 7 días	Histerectomía
Toupetes severos FR < 6ppm	Neurológico: Convulsiones		Administración > 3 vol. de hemoderivados: si no	Ingreso de UCI > 7 días	Histerectomía
	Neurológico: Convulsiones		Administración > 3 vol. de hemoderivados: si no	Ingreso de UCI > 7 días	Histerectomía

RECÉN NACIDO		P. CEFÁLICO cm		EDAD GESTACIONAL		PESO E.G.		APGAR (min)		FALLECE EN LUGAR DE PARTO		ATENCIÓN MÉDICO COST. ENI. AUX. ESTUD. EMP. ORO		NOMBRE	
SEXO H M	PESO AL NACER	LONGITUD cm	ESTIMADA	sem. dist.	FUM	ECO	gde	1*	5*	10*	si no	si no	si no	si no	si no

MÉTODO CANGURO		DEFECTOS CONGÉNITOS		ENFERMEDADES		TAMIZAJE METABOLICO		TAMIZAJE AUDITIVO		VACUNA		APOYO INMEDIATO		MECONIO 1º día	
Amenal	Se aplica	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no

EGRESO RN		FALLECE EN LUGAR DE LA REFERENCIA		FALLECE EN EL LUGAR DE LA REFERENCIA		ALIMENTO AL ALTA		DECUBITO SUPINO		EGRESO MATERNO		FALLECE EN LUGAR DE LA REFERENCIA		FALLECE EN EL LUGAR DE LA REFERENCIA		ANTICONCEPCIÓN	
si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	si no	